Université de Poitiers
Faculté de Médecine et Pharmacie

ANNEE 2019

THESE
POUR LE DIPLOME D'ETAT
DE DOCTEUR EN MEDECINE
(décret du 16 janvier 2004)

présentée et soutenue publiquement
le 10 octobre 2019 à Poitiers
par Monsieur Laurent TURPIN

Lien entre les profils de personnalités et l'épuisement professionnel, l'empathie et le trouble de stress post-traumatique chez les internes en Médecine de la faculté de Poitiers

COMPOSITION DU JURY

Président : Monsieur le Professeur René ROBERT

Membres : Monsieur le Docteur Philippe BOUTIN
Madame Nelly GOUTAUDIER, maître de conférence - département de Psychologie
Madame le Professeur Stéphanie MIGNOT

Directeur de thèse : Monsieur le Professeur François BIRAULT

Année universitaire 2019 - 2020

LISTE DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE

Professeurs des Universités-Praticiens Hospitaliers

- BOULETI Claire, cardiologie **(absente jusque début mars 2020)**
- BRIDOUX Frank, néphrologie
- BURUCOA Christophe, bactériologie – virologie
- CHEZE-LE REST Catherine, biophysique et médecine nucléaire
- CHRISTIAENS Luc, cardiologie
- CORBI Pierre, chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
- DAHYOT-FIZELIER Claire, anesthésiologie – réanimation
- DEBAENE Bertrand, anesthésiologie réanimation
- DEBIAIS Françoise, rhumatologie
- DROUOT Xavier, physiologie
- DUFOUR Xavier, Oto-Rhino-Laryngologie
- FAURE Jean-Pierre, anatomie
- FRASCA Denis, anesthésiologie-réanimation
- FRITEL Xavier, gynécologie-obstétrique
- GAYET Louis-Etienne, chirurgie orthopédique et traumatologique
- GERVAIS Elisabeth, rhumatologie
- GICQUEL Ludovic, pédopsychiatrie
- GILBERT Brigitte, génétique
- GOMBERT Jean-Marc, immunologie
- GOUJON Jean-Michel, anatomie et cytologie pathologiques
- GUILLEVIN Rémy, radiologie et imagerie médicale
- HAUET Thierry, biochimie et biologie moléculaire
- HOUETO Jean-Luc, neurologie
- INGRAND Pierre, biostatistiques, informatique médicale
- ISAMBERT Nicolas, cancérologie
- JAAFARI Nematollah, psychiatrie d'adultes
- JABER Mohamed, cytologie et histologie
- JAYLE Christophe, chirurgie thoracique t cardio-vasculaire
- KARAYAN-TAPON Lucie, cancérologie
- KEMOUN Gilles, médecine physique et de réadaptation **(en détachement)**
- KRAIMPS Jean-Louis, chirurgie générale
- LECLERE Franck, chirurgie plastique, reconstructrice
- LECRON Jean-Claude, biochimie et biologie moléculaire
- LELEU Xavier, hématologie
- LEVARD Guillaume, chirurgie infantile
- LEVEQUE Nicolas, bactériologie-virologie
- LEVEZIEL Nicolas, ophtalmologie
- MACCHI Laurent, hématologie
- MCHEIK Jiad, chirurgie infantile
- MEURICE Jean-Claude, pneumologie
- MIGEOT Virginie, santé publique
- MILLOT Frédéric, pédiatrie, oncologie pédiatrique
- MIMOZ Olivier, anesthésiologie – réanimation
- NEAU Jean-Philippe, neurologie
- ORIOT Denis, pédiatrie
- PACCALIN Marc, gériatrie
- PERAULT Marie-Christine, pharmacologie clinique
- PERDRISOT Rémy, biophysique et médecine nucléaire
- PIERRE Fabrice, gynécologie et obstétrique
- PRIES Pierre, chirurgie orthopédique et traumatologique
- RAMMAERT-PALTRIE Blandine, maladies infectieuses
- RICHER Jean-Pierre, anatomie
- RIGOARD Philippe, neurochirurgie
- ROBERT René, réanimation
- ROBLOT France, maladies infectieuses, maladies tropicales
- ROBLOT Pascal, médecine interne
- RODIER Marie-Hélène, parasitologie et mycologie
- SAULNIER Pierre-Jean, thérapeutique
- SCHNEIDER Fabrice, chirurgie vasculaire
- SILVAIN Christine, hépato-gastro- entérologie
- TASU Jean-Pierre, radiologie et imagerie médicale
- THIERRY Antoine, néphrologie
- THILLE Arnaud, réanimation
- TOUGERON David, gastro-entérologie
- WAGER Michel, neurochirurgie
- XAVIER Jean, pédopsychiatrie

Maîtres de Conférences des Universités-Praticiens Hospitaliers

- ALBOUY-LLATY Marion, santé publique
- BEBY-DEFAUX Agnès, bactériologie – virologie
- BEN-BRIK Eric, médecine du travail **(en détachement)**
- BILAN Frédéric, génétique
- BOISSON Matthieu, anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire
- BOURMEYSTER Nicolas, biologie cellulaire
- CASTEL Olivier, bactériologie - virologie – hygiène
- CAYSSIALS Emilie, hématologie
- COUDROY Rémy, réanimation
- CREMNITER Julie, bactériologie – virologie
- DIAZ Véronique, physiologie
- FROUIN Eric, anatomie et cytologie pathologiques
- GARCIA Magali, bactériologie-virologie
- JAVAUGUE Vincent, néphrologie
- KERFORNE Thomas, anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire
- LAFAY Claire, pharmacologie clinique
- MARTIN Mickaël, médecine interne
- PALAZZO Paola, neurologie
- PERRAUD Estelle, parasitologie et mycologie
- SAPANET Michel, médecine légale
- THUILLIER Raphaël, biochimie et biologie moléculaire

Professeur des universités

- PELLERIN Luc, biochimie et biologie moléculaire

Professeur des universités de médecine générale

- BINDER Philippe

Bât. D1 - 6 rue de la Milétrie – TSA 51115 - 86073 POITIERS CEDEX 9 - France
☎05.49.45.43.43 - 🖷 05.49.45.43.05

Professeurs associés de médecine générale

- BIRAULT François
- FRECHE Bernard
- MIGNOT Stéphanie
- PARTHENAY Pascal
- VALETTE Thierry
- VICTOR-CHAPLET Valérie

Maîtres de Conférences associés de médecine générale

- AUDIER Pascal
- ARCHAMBAULT Pierrick
- BRABANT Yann

Enseignants d'Anglais

- DEBAIL Didier, professeur certifié

Professeurs émérites

- ALLAL Joseph, thérapeutique (08/2020)
- BATAILLE Benoît, neurochirurgie (08/2020)
- CARRETIER Michel, chirurgie générale (08/2021)
- DORE Bertrand, urologie (08/2020)
- GIL Roger, neurologie (08/2020)
- GOMES DA CUNHA José, médecine générale (08/2021)
- GUILHOT-GAUDEFFROY François, hématologie et transfusion (08/2020)
- HERPIN Daniel, cardiologie (08/2020)
- KITZIS Alain, biologie cellulaire (16/02/2021)
- MARECHAUD Richard, médecine interne (24/11/2020)
- MAUCO Gérard, biochimie et biologie moléculaire (08/2021)
- RICCO Jean-Baptiste, chirurgie vasculaire (08/2020)
- SENON Jean-Louis, psychiatrie d'adultes (08/2020)
- TOUCHARD Guy, néphrologie (08/2021)

Professeurs et Maîtres de Conférences honoraires

- AGIUS Gérard, bactériologie-virologie
- ALCALAY Michel, rhumatologie
- ARIES Jacques, anesthésiologie-réanimation
- BABIN Michèle, anatomie et cytologie pathologiques
- BABIN Philippe, anatomie et cytologie pathologiques
- BARBIER Jacques, chirurgie générale (ex-émérite)
- BARRIERE Michel, biochimie et biologie moléculaire
- BECQ-GIRAUDON Bertrand, maladies infectieuses, maladies tropicales (ex-émérite)
- BEGON François, biophysique, médecine nucléaire
- BOINOTCatherine, hématologie – transfusion
- BONTOUX Daniel, rhumatologie (ex-émérite)
- BURIN Pierre, histologie
- CASTETS Monique, bactériologie -virologie – hygiène
- CAVELLIER Jean-François, biophysique et médecine nucléaire
- CHANSIGAUD Jean-Pierre, biologie du développement et de la reproduction
- CLARAC Jean-Pierre, chirurgie orthopédique
- DABAN Alain, cancérologie radiothérapie (ex-émérite)
- DAGREGORIO Guy, chirurgie plastique et reconstructrice
- DESMAREST Marie-Cécile, hématologie
- DEMANGE Jean, cardiologie et maladies vasculaires
- EUGENE Michel, physiologie (ex-émérite)
- FAUCHERE Jean-Louis, bactériologie-virologie (ex-émérite)
- FONTANEL Jean-Pierre, Oto-Rhino Laryngologie (ex-émérite)
- GRIGNON Bernadette, bactériologie
- GUILLARD Olivier, biochimie et biologie moléculaire
- GUILLET Gérard, dermatologie
- JACQUEMIN Jean-Louis, parasitologie et mycologie médicale
- KAMINA Pierre, anatomie (ex-émérite)
- KLOSSEK Jean-Michel, Oto-Rhino-Laryngologie
- LAPIERRE Françoise, neurochirurgie (ex-émérite)
- LARSEN Christian-Jacques, biochimie et biologie moléculaire
- LEVILLAIN Pierre, anatomie et cytologie pathologiques
- MAIN de BOISSIERE Alain, pédiatrie
- MARCELLI Daniel, pédopsychiatrie (ex-émérite)
- MARILLAUD Albert, physiologie
- MENU Paul, chirurgie thoracique et cardio-vasculaire (ex-émérite)
- MORICHAU-BEAUCHANT Michel, hépato-gastro-entérologie
- MORIN Michel, radiologie, imagerie médicale
- PAQUEREAU Joël, physiologie
- POINTREAU Philippe, biochimie
- POURRAT Olivier, médecine interne (ex-émérite)
- REISS Daniel, biochimie
- RIDEAU Yves, anatomie
- SULTAN Yvette, hématologie et transfusion
- TALLINEAU Claude, biochimie et biologie moléculaire
- TANZER Joseph, hématologie et transfusion (ex-émérite)
- TOURANI Jean-Marc, cancérologie
- VANDERMARCQ Guy, radiologie et imagerie médicale

Bât. D1 - 6 rue de la Milétrie – TSA 51115 - 86073 POITIERS CEDEX 9 - France
☎05.49.45.43.43 - 🖷 05.49.45.43.05

REMERCIEMENTS

A Monsieur le Professeur René ROBERT, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier en Réanimation. Vous me faites l'honneur de présider cette thèse. Veuillez recevoir l'expression de ma sincère gratitude et de mon profond respect.

A Madame Nelly GOUTAUDIER, merci pour votre compétence et passion pour les statistiques. Vous me faites l'honneur d'accepter de juger ce travail, veuillez trouver ici toute l'expression de ma reconnaissance.

A Monsieur le Docteur Philippe BOUTIN, Docteur en Médecine Générale. Vous me faites l'honneur de juger ce travail. Veuillez recevoir l'expression de mes sincères remerciements.

A Madame le Professeur MIGNOT Stéphanie, Professeur associé de Médecine Générale. Vous me faites l'honneur de juger cette thèse. Veuillez recevoir tout mon respect et ma gratitude.

A Monsieur le Professeur François BIRAULT, Professeur Associé de Médecine Générale. Je vous remercie de m'avoir confié ce sujet et vous remercie pour votre temps. Soyez assuré de ma gratitude et de mon profond respect.

A Amélie et Adrien, cela a été un plaisir de travailler avec vous et de vous rencontrer. Je vous souhaite le meilleur pour la suite.

A Anis pour son aide.

A tous les étudiants de TCEM1 de Médecine Générale de la promotion 2018-2019 qui ont bien voulu répondre à notre étude.

REMERCIEMENTS PERSONNELS

A mes parents, mes soeurs et toute ma famille, merci de m'avoir fait tel que je suis, à priori sans SPI pathologique.

A ma belle-famille, merci de m'avoir accepté parmi vous.

A tous mes amis, ceux du Primaire, du Collège, du Lycée, de la Faculté et aussi à tous ceux rencontrés au bord d'un bassin, merci pour votre bonne humeur.

A Isabelle, Katia et Olivier qui m'ont fait découvrir et aimer la Médecine Générale.

A Cécile et Roselyne, qui me permettent de continuer à aimer la Médecine Générale libérale grâce à leur redoutable efficacité.

A Inès, merci pour tout et merci pour ces magnifiques semaines de vacances de septembre. La route est belle en ta compagnie.

Liste des abréviations

AP : Accomplissement personnel
BFI-Fr : Big Five Inventory version Française
BO : burnout
DEP : Dépersonnalisation
DFASM : Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales
DFGSM : Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales
DSM 5 : Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 5ème version
Ec : Empathie Cognitive
EC : Empathic Concern
Ee : Empathie Emotionnelle
EE : Epuisement Emotionnel
EP : Epuisement Professionnel
ESPT : état de stress post-traumatique
FS : Fantasy
IRI : Index de Réactivité Interpersonnel
LEC-5 : Life Event Checklist for DSM 5
MBI : Maslach Burnout Inventory
PACES : Première Année Commune aux Etudes de Santé
PCL-5 : Posttraumatic stress disorder Check List For DSM 5
PD : Personal Distress
PDI : Peritraumatic Distress Inventory
PT : Perspective Taking
PTGI : Post Traumatic Growth Inventory
SEP : Syndrome d'Epuisement Professionnel
SPI : Schéma Précoce Inadapté
SSPT : Syndrome de Stress Post-Traumatique
TCEM1 : 1ère année du Troisième Cycle des Etudes Médicales
YSQ-S3 : Young's Schema Questionnaire , 3ème version courte

Table des matières

1/ INTRODUCTION 9
2/ MATERIELS ET METHODES 14
2.1.Conception de l'étude 14
2.2. Échelles utilisées 14
2.2.1. Questionnaires des schémas de Young , 3ème version courte : YSQ-S3 14
2.2.2. Big Five Inventory version française : BFI-Fr 14
2.2.3. Maslach Burnout Inventory : MBI 15
2.2.4. Index de réactivité interpersonnelle : IRI 15
2.2.5. Life Event Checklist for DSM-5: LEC-5 15
2.2.6. Peritraumatic Distress Inventory : PDI, Inventaire de détresse péri-traumatique 16
2.2.7. PTSD Check List For DSM 5 : PCL-5 16
2.2.8. Post Traumatic Growth Inventory : PTGI 16
2.2.9. Caractéristiques générales de la population 17
2.3. Analyse statistique 17
3/ RÉSULTATS 18
3.1. Participation des étudiants 18
3.2. Résultats du YSQ-S3 18
3.3. Mise en évidence de profils de personnalités 19
3.5. Description des résultats du LEC-5 par cluster 23
3.6. Description des paramètres démographiques en fonction des clusters 29
3.7. Recherche de corrélation entre profil de personnalité et résultats aux différents tests 30
3.8. Comparaison des moyennes des scores à l'IRI, au MBI, aux SPI 11, 12, 13, 18, au Big Five et au PDI ; entre les premiers répondeurs et ceux avec relance 31
4/ DISCUSSION 32
4.1. Généralités 32
4.2. Limites et biais de l'enquête 32
4.2.1. Puissance/ taux de participation 32
4.2.2. Biais de sélection 32
4.2.3. Biais lié à l'interprétation des résultats 32
4.2.4. Biais de déclaration 32
4.2.5. Biais de confusion 33

4.2.6. Biais de mesure 33
4.3. Analyse des résultats 33
4.3.1. Taux d'exposition à un événement traumatique.....33
4.3.2. YSQ-S3 34
4.3.3. PDI 34
4.3.4. IRI 34
4.3.5. Modèle des cinq grands facteurs de personnalité 35
4.3.6. MBI.....35
4.3.7. Comparaison des moyennes des scores à l'IRI, au MBI, aux SPI 11, 12, 13, 18, au BFI-Fr et au PDI ; entre les premiers répondeurs et ceux avec relance 35
4.4. Moyens proposés.....36
5/ CONCLUSION 37
6/ BIBLIOGRAPHIE.....38
7/ ANNEXES 43
Annexe n°1 - QUESTIONNAIRE DES SCHÉMAS DE YOUNG (YSQ-S3).....43
Annexe n°2 - BIG FIVE INVENTORY version française : BFI-Fr 48
Annexe n°3 - MASLACH BURNOUT INVENTORY : MBI 50
Annexe n°4 - INDEX DE REACTIVITE INTERPERSONELLE 52
Annexe n°5 - LIFE EVENT CHECKLIST for DSM-5 54
Annexe n°6 - PERITRAUMATIC DISTRESS INVENTORY.....56
Annexe n° 7 - PTSD CHECK LIST for DSM-5; PCL-5 58
Annexe n°8 - POST TRAUMATIC GROWTH INVENTORY : PTGI 60
Annexe n°9 - TROUBLE DE STRESS POST TRAUMATIQUE.....62
RÉSUMÉ 66
SERMENT.....67

1/ INTRODUCTION

Selon Young, les schémas précoces inadaptés (SPI) représentent des modèles ou des thèmes importants et envahissants pour l'individu. Ils sont constitués de souvenirs, d'émotions, de pensées et de sensations corporelles. Ils concernent la personne et ses relations avec les autres. Ils se sont développés au cours de l'enfance ou de l'adolescence. Ils se sont enrichis et complexifiés tout au long de la vie. Cinq grands domaines de fonctionnement sont explorés : séparation et rejet, manque d'autonomie et de performance, manque de limites, orientation vers les autres, sur-vigilance et inhibition.
Le schéma n'est pas un comportement, mais les stratégies individuelles d'adaptation vont entrainer un style relationnel particulier pour tenter de résoudre les problèmes qu'il pose. Ainsi, une personne qui se sent inférieure peut, soit devenir égocentrique pour compenser (personnalité narcissique), soit se vouloir persécutée (personnalité paranoÏaque), ou encore chercher la protection d'autrui (personnalité dépendante).
Les SPI se traduisent dans des comportements auto-défaitistes qui apparaissent très tôt dans le développement, et se répètent tout au long de la vie. Les contenus des schémas sont latents et évités par le sujet qui ne peut reconnaitre qu'ils guident sa vie. Ils représentent donc un des éléments constitutifs de la personnalité et sont à la source des scénarios de vie, selon lesquels un individu va répéter sans cesse les mêmes erreurs, en croyant que sa vie va changer (1).

Une étude menée chez des professionnels de la santé mentale (2), a montré que les deux SPI les plus présents étaient Idéaux Exigeants (s'efforcer d'atteindre et de maintenir un niveau de perfection très élevé) et Abnégation (souci de combler les besoins des autres au détriments des siens).

La personnalité peut aussi être évaluée par le modèle des cinq grands facteurs de personnalité, ou Big Five. C'est un système de classification de la personnalité qui mesure les traits de la personnalité. Les cinq personnalités sont O (Ouverture, Originalité, Ouverture d'esprit); C (Conscience, Contrôle, Contrainte); E (Extraversion, Énergie, Enthousiasme); A (Agréabilité, Altruisme, Affection); N (Émotions Négatives, Névrosisme, Nervosité), le modèle « OCEAN ».

Selon Oliver P.John et Sanjay Srivastava (3), « l'Extraversion implique une approche enthousiaste du monde matériel et social incluant des caractéristiques telles que la sociabilité, l'activité, l'affirmation de soi et l'émotion positive. L'Agréabilité contraste avec une orientation pro-sociale et communautaire envers les autres […] et

inclus des traits tels que l'altruisme, la tendresse d'esprit, la confiance et la modestie. La Conscience décrit le contrôle socialement autorisé des impulsions qui facilite les comportements orientés vers les tâches et les objectifs, tels que réfléchir avant d'agir, retarder la gratification, respecter des normes et des règles, planifier, organiser et hiérarchiser des tâches. Le Névrosisme oppose une stabilité émotionnelle et une humeur égale avec une émotion négative, telle que se sentir anxieux, nerveux, triste et tendu. L'Ouverture à l'expérience (par opposition à l'étroitesse d'esprit) décrit l'ampleur, la profondeur, l'originalité et la complexité de la vie mentale et expérimentale d'un individu.

On sait que la population de soignants est fortement touchée par le Burnout (BO). Une étude récente retrouve un BO chez 49% des médecins Français avec 5% de forme sévère (4).

D'après Maslach, le burnout est le résultat d'une exposition prolongée et insoluble au stress émanant de la sphère professionnelle : un déséquilibre entre les demandes liées au travail et les ressources et attentes dont dispose l'individu pour y faire face (5).

Le syndrome d'épuisement professionnel (SEP) est un syndrome psychologique d'épuisement professionnel (EE), de dépersonnalisation (DEP), et d'une diminution de l'accomplissement personnel (AP) qui peut survenir chez les personnes travaillant avec d'autres personnes, à quelque titre que ce soit (6).

L'EE est typiquement lié au rapport avec un travail vécu comme difficile, fatiguant, stressant. La DEP, ou perte d'empathie, se caractérise par une baisse de considération positive envers les autres. L'AP est un sentiment de « soupape de sécurité », qui assurerait un équilibre en cas d'épuisement professionnel et de dépersonnalisation (7).

Bamber et McMahon (8) ont constaté, au sein d'une NHS (National Health Service), que des scores plus élevés de manque affectif (certitude que les autres ne donneront pas le soutien affectif nécessaire) prédisaient l'EE, tandis que l'assujettissement (soumission excessive au contrôle des autres) et le droit personnel exagéré (affirmation que l'on est supérieur aux autres, et que l'on a, de ce fait, des droits spéciaux et des privilèges) prédisaient une DEP. Le surcontrôle émotionnel (la conviction qu'il faut maîtriser ses émotions) prédisait une diminution de l'AP.

Chez les psychologues, les deux SPI majoritaires étaient idéaux exigeants / critique excessive et abnégation. Dans ces SPI, il y avait un fort taux d'EE, avec 18,3% dans la fourchette haute et 29,6% dans la fourchette modérée (9).

Une autre étude menée sur des « volunteer counselors » en soins palliatifs, montrait que l'EE était prédit par le Névrosisme, la DEP par le Névrosisme, l'Extraversion et l'Ouverture, l'AP par l'Extraversion et le Névrosisme (10).

D'autres facteurs peuvent entrer en compte dans la survenue d'un BO, comme l'empathie. Plusieurs études ont noté une relation entre empathie et épuisement professionnel : plus le niveau d'épuisement professionnel des médecins généralistes était élevé, plus leur empathie était faible (11,12).

En 1961 (13), Carl Rogers définit l'empathie comme la capacité de ressentir le monde intérieur des clients comme s'il s'agissait du nôtre.

Selon Davis (14), l'empathie est conceptualisée en tant que modèle à deux composants, intégrant à la fois une facette affective (empathie émotionnelle ou Ee) et une facette cognitive (empathie cognitive ou Ec).
Ainsi, l'empathie fait référence à un phénomène qui « requiert à la fois la capacité de partager l'expérience émotionnelle de l'autre personne (composante affective) et une compréhension de l'expérience de cette personne (composante cognitive) » (15).

Davis propose une approche multidimensionnelle de l'empathie avec quatre sous composantes qui sont :
- la prise de perspective (« perspective taking » ou PT), qui correspond à la capacité à adopter le point de vue des autres,
- la sollicitude ou préoccupation empathique («empatic concern» ou EC), qui évalue les sentiments de sympathie et d'inquiétude envers les autres,
- la détresse personnelle (« personal distress » ou PD), qui correspond à la capacité de ressentir et de vivre la détresse de l'autre,
- la fantaisie (« fantasy » ou FS), qui correspond à l'imaginaire, au fait de se projeter dans les sentiments de personnages fictifs (BD, films, théâtre).

L'empathie cognitive (Ec) est représentée par la PT et la FS tandis que l'empathie émotionnelle (Ee) est représentée par l'EC et la PD.

L'index de réactivité interpersonnelle (IRI, annexe n°7) permet de mesurer les différentes composantes de l'empathie.

Enfin, la personnalité semble influencer sur la survenue ou non d'un Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT).

Selon le Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 5ème version (DSM-V), une personne est atteinte d'un TSPT lorsqu'elle « a été confrontée à la mort ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles » (critère A); qu'elle « présente un ou plusieurs symptômes d'intrusion […] associé à un ou plusieurs événements traumatisants, qui sont apparus après que le ou les événements traumatisants se soient produits » (critère B); qu'il existe un « évitement persistant des stimuli associés à un ou plusieurs événements traumatiques, ayant débuté après que celui-ci ou ceux-ci se soient produits » (critère C); qu'il existe des « altérations des cognitions et de l'humeur associées à un ou plusieurs événements traumatiques, qui ont commencé ou ont empiré après la survenue du ou des événements traumatiques » (critère D); qu'il existe de « profondes modifications de l'état d'éveil et de la réactivité associées à un ou plusieurs événements traumatiques, qui ont commencé ou ont empiré après que l'événement traumatisant s'est produit» (critère E); que «la perturbation (les symptômes décrits aux critères B, C, D, et E) dure plus d'un mois (critère F); que « la perturbation entraine une souffrance cliniquement significative, ou une incapacité importante dans les dimensions sociale, professionnelle, ou tout autre dimension importante du fonctionnement » (critère G) et que « la perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance ou à une autre affection» (critère H). (Annexe n°9).

Selon Benjet (16), 70,4% de la population mondiale a vécu un événement traumatique.

Kessler estime que la prévalence mondiale du TSPT est de 7,8% (17) et Kilpatrick (18) estime qu'aux Etats Unis, dans la population générale, les taux de prévalence de l'état de stress post-traumatique (ESPT) au cours de la vie, des 12 derniers mois, et des 6 derniers mois sont respectivement d'environ 8,3%; 4,7% et 3,8%.

Les professionnels de santé semblent plus touchés par le TSPT. En effet, 22% des internes en chirurgie (19) et 33% du personnel d'un service de réanimation en souffraient (20).

Les personnes atteintes de TSPT ont un risque accru de développer des troubles psychiatriques, de l'anxiété, des troubles affectifs, une toxicomanie (21).

Une analyse portant sur 127 femmes ayant subit des violences sexuelles dans l'enfance, a montré que les victimes ayant les schémas de méfiance / abus, peur du

danger / de la maladie et manque affectif avaient un TSPT plus grave que les autres (22).

Une autre étude menée sur des femmes suite à la guerre en Croatie, montre qu'un Névrosisme élevé et qu'une extraversion faible sont des facteurs indépendants, associés à un niveau plus élevé de symptômes du TSPT chez les femmes civiles victimes de la guerre (23).

Une étude récente a retrouvé qu'un Névrosisme élevé était significativement lié au développement de TSPT et de croissance post-traumatique chez les étudiants en médecine de la faculté de Poitiers (24).

Par ailleurs, Palgi (25) indique que les patients atteints de TSPT ont des déficits d'aptitudes empathiques, à la fois émotionnelles et cognitives, et que leurs difficultés d'empathie peuvent sous-tendre leurs déficiences d'aptitudes sociales et interpersonnelles.

À notre connaissance, il n'existe pas d'étude ayant recherché de lien entre les SPI et le BO, l'empathie, le Big Five et le TSPT chez les internes de médecine générale.

Dans cette étude portant sur la promotion d'internes du troisième cycle des études médicales en première année (TCEM1) de médecine générale de l'Université de Poitiers, nous allons rechercher s'il existe un lien entre la personnalité et le BO, l'empathie, le Big Five et le TPST.

Le critère de jugement principal étant : lien statistique entre certaines personnalités et un épuisement professionnel.
Secondairement, nous nous demanderons si les premiers répondeurs (sans relance), sont représentatifs de la population étudiée, avec comme critère de jugement principal : comparaison des moyennes avec test statistique avec $p<0,05$.

2/ MATERIELS ET METHODES

2.1.Conception de l'étude

Un questionnaire a été remis aux étudiants TCEM 1, en médecine générale de l'Université de Poitiers, lors de leur journée de rentrée, en octobre 2018.
Afin d'obtenir plus de réponses, nous sommes de nouveau allés proposer le questionnaire lors de leur premier séminaire de novembre à décembre 2018, pour les non répondants de la journée de rentrée.

2.2. Échelles utilisées

2.2.1. Questionnaires des schémas de Young , 3ème version courte : YSQ-S3

Il s'agit de la dernière version du Questionnaire des Schémas de Young (Annexe n°1) servant à identifier les SPI prédominants chez un individu. Chaque schéma est évalué au travers de cinq questions, soit un total de 90 questions pour les 18 SPI.
Les participants répondent à chacune des 90 questions au moyen d'une échelle de Likert allant de 1 « cela est complètement faux pour moi » à 6 « me décrit parfaitement ».
Les propriétés psychométriques du questionnaire français du YSQ-S3 ont été validées (26).

2.2.2. Big Five Inventory version française : BFI-Fr

Le BFI (Annexe n°2) fut créé par John et ses collègues pour donner aux chercheurs et aux cliniciens un moyen efficace, sûr et valide de mesurer les différences individuelles selon les cinq grandes dimensions. Le BFI a été élaboré avec des buts précis.

Le premier est sa brièveté et cela de deux façons, du fait du petit nombre d'items et du fait d'un temps de remplissage extrêmement court.

Le second but est la simplicité pour les participants aux recherches à comprendre le questionnaire. Il est soit utilisé comme auto-questionnaire, soit utilisé pour décrire une tierce personne. Enfin, le contenu des items est énoncé en langage quotidien.

Le troisième but est sa facilité de cotation.
Les participants répondent à chacune des 45 questions au moyen d'une échelle de Likert allant de 1 « désapprouve fortement » à 5 « approuve fortement » (27, 28).
La traduction française de cette échelle a été validée (29).

2.2.3. Maslach Burnout Inventory : MBI

Le MBI (Annexe n°3) est un questionnaire de vingt-deux items permettant d'explorer les trois dimensions du BO qui sont :

- l'épuisement professionnel (9 items), qui est typiquement lié au rapport avec un travail vécu comme difficile, fatiguant, stressant… Pour Maslach, il est différent d'une dépression car il disparait pendant les vacances.

- la dépersonnalisation (5 items), ou perte d'empathie, se caractérisant par une baisse de considération positive à l'égard des autres (clients, collègues...), c'est une attitude où la distance émotionnelle est importante, observable par des discours cyniques, dépréciatifs, voire même par de l'indifférence.

- l'accomplissement personnel (8 items) est un sentiment « soupape de sécurité » qui assurerait un équilibre en cas d'épuisement professionnel et de dépersonnalisation. Il assure un épanouissement au travail, un regard positif sur les réalisations professionnelles.

Les réponses sont données sur une échelle de fréquence en 7 points de « jamais » à « tous les jours ». Des scores élevés d'EP et de DEP vont dans le sens d'un état de burnout important. À l'inverse, des scores élevés d'accomplissement personnel vont dans le sens d'un état de burnout faible ou inexistant (7, 30).

2.2.4. Index de réactivité interpersonnelle : IRI

L'IRI (annexe n°4) est un outil de mesure publié pour l'évaluation multidimensionnelle de l'empathie, développé par Mark H. Davis (31).
Il s'agit d'un questionnaire d'auto-évaluation comprenant 28 réponses sur une échelle de Likert en cinq points allant de A « Ne me décrit pas bien» à E «Me décrit très bien».

Les quatre sous-échelles sont Prise de perspective (PT) , Fantaisie (FS), Préoccupation empathique (EC), Détresse personnelle (PD).

L'Empathie cognitive (Ec) est représentée par la PT et la FS tandis que l'Empathie émotionnelle (Ee) est représentée par l'EC et la PD.

La traduction française de cet outil a été validée (32).

2.2.5. Life Event Checklist for DSM-5: LEC-5

La LEC-5 (annexe n°5) est une liste d'auto-évaluation conçue pour dépister les événements potentiellement traumatisants au cours de la vie du répondant. Il évalue l'exposition à 16 événements susceptibles d'entraîner un TSPT ou une détresse, et

inclus un élément supplémentaire évaluant tout autre événement extrêmement stressant non pris en compte dans les 16 premiers éléments.

Le LEC-5 ne produit pas de score total ou composite, il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres mesures (par exemple, CAPS-5, PCL-5) dans le but d'établir l'exposition à un événement traumatisant du critère A de l'ESPT (33, 34, 35).

2.2.6. Peritraumatic Distress Inventory : PDI, Inventaire de détresse péri-traumatique

Le PDI (annexe n°6) est un questionnaire d'auto-évaluation de 13 items permettant de déterminer les réactions de détresse émotionnelle d'une personne, au moment d'un événement traumatique et dans les minutes et les heures qui suivent. Les personnes qui présentent une forte détresse péri-traumatique ont plus de risque de développer des TSPT.

Chacun des 13 items est coté sur une échelle de Likert de 0 (pas du tout vrai) à 4 (extrêmement vrai). Le score total est la somme de tous les items. Un score à partir de 15 indique une détresse significative (36).

Il existe une validation française de cette échelle (37).

2.2.7. PTSD Check List For DSM 5 : PCL-5

Le PCL-5 (annexe n°7) est un auto-questionnaire de 20 items évaluant les 20 symptômes du TSPT selon le DSM-5 (38).

Il a plusieurs utilités :

- Évaluer les changements dans les symptômes avant et après le traitement,
- Dépister les individus avec un TSPT,
- Établir un diagnostic provisoire du TSPT.

2.2.8. Post Traumatic Growth Inventory : PTGI

L'inventaire de croissance post-traumatique (annexe n°8) a été mis au point après avoir compris que les changements positifs survenus après les événements stressants étaient sous-reconnus. C'est un instrument d'évaluation des résultats positifs rapportés par les personnes ayant vécu des événements traumatiques. Le PTGI est composé de 21 éléments et l'échelle de réponse est une échelle de Likert en six points, demandant aux répondants quel est le degré de changement dans leur vie à la suite de

l'événement traumatique, où 0 représente «Je ne ressens pas ce changement» et 5 représente «Je ressens ce changement à un degré très élevé».

Le score total est la somme de tous les items (score maximum 105 points).
L'analyse se compose de 5 sous-échelles :

- Relation aux autres (items 6, 8, 9, 15, 16, 20, 21),
- Nouvelles possibilités (items 3, 7, 11, 14, 17),
- Force personnelle (items 4, 10, 12, 19),
- Changement spirituel (items 5, 18),
- Appréciation de la vie (items 1,2, 13)

La traduction française de cette échelle a été validée (39, 40).

2.2.9. Caractéristiques générales de la population

- Démographiques (âge, nationalité, sexe, statut matrimonial)
- Professionnelles (redoublement)
- Personnelles (célibataire, en couple, vivant seul ou non)

2.3. Analyse statistique

L'enquête effectuée est une étude épidémiologique observationnelle descriptive transversale. L'analyse de classification a été utilisée pour identifier des groupes homogènes basés sur les scores standardisés au test YSQ-S3. Une analyse hiérarchique utilisant la méthode d'agrégation de Ward et la distance euclidienne a d'abord identifié le nombre de groupes en se basant sur le dendrogramme. Puis la méthode des nuées dynamiques (K-means clustering) a été utilisée pour assigner chaque sujet à l'un des groupes identifiés. Des ANOVAS ont ensuite été utilisées pour mesurer les différences significatives entre les groupes avec le logiciel Statistica (Statistica, StatSoft, Inc. 2011).

3/ RÉSULTATS

3.1. Participation des étudiants

Quatre-vingt douze étudiants sur cent dix ont participé à l'étude soit 83,6% de la promotion 2018-2019 de la population étudiée.
En revanche, le taux de remplissage du PCL-5 a été seulement de 17,4%, nous avons donc décidé de ne pas traiter les résultats du PCL-5 et du PTGI devant la faible puissance de l'étude.

3.2. Résultats du YSQ-S3

Tableau 1. Moyennes des différents SPI de la population étudiée.

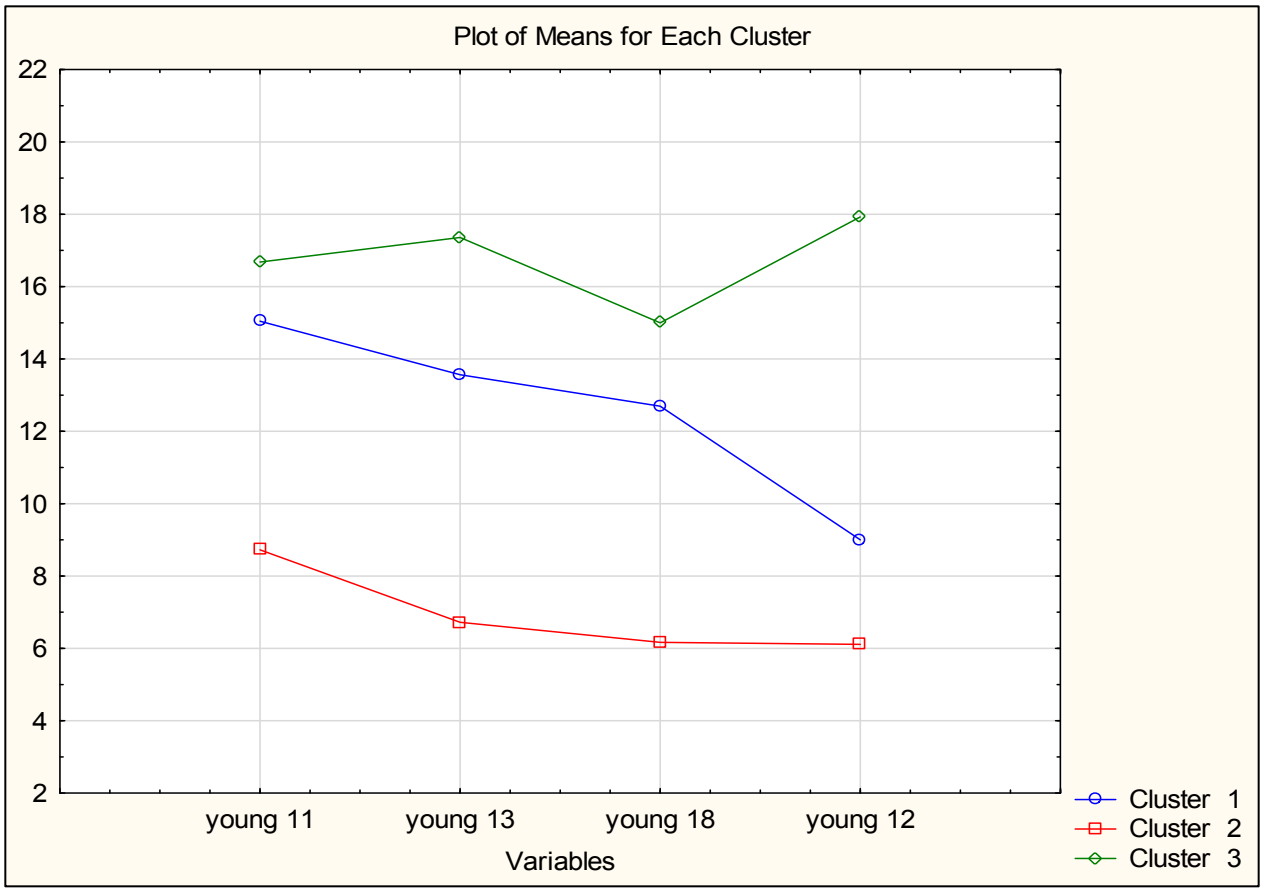
Résultats aux 18 SPI du YSQ-S3

	M	Extremes	DS
Manque affectif	7,6	0-24	4,135241
Abandon	9,9	0-24	4,368302
Méfiance et abus	9,5	0-24	5,041396
Isolement social	9,2	0-27	5,193198
Imperfection / honte	6,8	0-19	3,135650
Echec	10,3	0-25	5,181835
Dépendance / Incompétence	8,4	0-24	3,579735
Vulnérabilité	8,1	0-21	3,712349
Fusionnement	7,5	0-19	3,602436
Assujettissement	7,9	0-20	3,424079
Abnégation	14,3	0-28	5,166968
Surcontrôle Emotionnel	11,2	0-28	5,578481
Idéaux Exigeants	13,4	0-24	4,994156
Droits Personnels Exagérés	10,9	0-23	4,374764
Contrôle de soi / Autodiscipline Insuffisant	9,6	0-25	4,241557
Recherche d'approbation et de reconnaissance	10,6	0-19	4,201605
Négativité / Pessimisme	10,5	0-28	4,993354
Punition	12,1	0-25	4,778253

3.3. Mise en évidence de profils de personnalités

L'analyse du coefficient d'agglomération et du dendrogramme basée sur les scores standardisés au YSQ-S3 a indiqué qu'un découpage en trois groupes était le plus approprié et que quatre SPI ressortaient dans la population étudiée, à savoir le SPI 11 (abnégation), 12 (surcontrôle émotionnel), 13 (idéaux exigeants) et 18 (punition).

Figure 1. Découpage en 3 clusters de la population de 92 participants selon les résultats standardisés du YSQ-S3.



Le groupe 1 (46 personnes soit 50 % de la population) était caractérisé par une forte abnégation, un surcontrôle émotionnel bas, des idéaux exigeants moyens et un SPI
« punition » moyen.

Le groupe 2 (18 personnes, soit 19,6% de la population) n'avait pas de fort SPI.

Le groupe 3 (28 personnes, soit 30,4% de la population) était caractérisé par une forte abnégation (supérieure au groupe 1), un surcontrôle émotionnel élevé, des idéaux exigent élevés et un SPI « punition » élevé.

3.4. Analyse des caractéristiques générales de la population en fonction des clusters

Tableau 2. Répartition selon l'âge et la nationalité

Cluster 1

	Hommes	Femmes	Total	Français	Autre Nationalité	Total
N	10	36	46	44	2	46
%	*22 %*	*78 %*	*100 %*	*96 %*	*4 %*	*100 %*

Cluster 2

	Hommes	Femmes	Total	Français	Autre Nationalité	Total
N	7	11	18	18	0	18
%	*39 %*	*61 %*	*100 %*	*100 %*	*0 %*	*100 %*

Cluster 3

	Hommes	Femmes	Non répondant	Total	Français	Autre Nationalité	Total
N	9	17	2	28	27	1	28
%	*32 %*	*61 %*	*7 %*	*100 %*	*96 %*	*4 %*	*100 %*

Tableau 3. Répartition selon la situation matrimoniale et le logement

Cluster 1

	Célibataire	En couple	Total	Vit seul	Vit en couple	Vit en colocation	Internat	Vit chez ses parents	Total
N	18	28	46	17	21	6	1	0	46
%	*39 %*	*61 %*	*100 %*	*37 %*	*48 %*	*13 %*	*2 %*	*0 %*	*100 %*

Cluster 2

	Célibataire	En couple	Total	Vit seul	Vit en couple	Vit en colocation	Vit chez ses parents	Total
N	4	14	18	4	11	2	1	18
%	*22 %*	*78 %*	*100 %*	*22 %*	*61 %*	*11 %*	*6 %*	*100 %*

Cluster 3

	Célibataire	En couple	Total	Vit seul	Vit en couple	Vit en colocation	Vit chez ses parents	Total
N	13	15	28	17	6	4	1	28
%	*46 %*	*54 %*	*100 %*	*61 %*	*21 %*	*14 %*	*4 %*	*100 %*

Tableau 4. Répartition selon le redoublement

Cluster 1

Redoublement	Oui	Non	Total	PACES	DFGSM2	DFGSM3	DFASM1	DFASM2	DFASM3
N	39	7	46	33	0	1	2	3	8
%	*85 %*	*15 %*	*100 %*	*72 %*	*0 %*	*2 %*	*4 %*	*6 %*	*17 %*

Cluster 2

Redoublement	Oui	Non	Total	PACES	DFGSM2	DFGSM3	DFASM1	DFASM2	DFASM3
N	12	6	18	11	0	0	0	0	1
%	*67 %*	*33 %*	*100 %*	*61 %*	*0 %*	*0 %*	*0 %*	*0 %*	*6 %*

Cluster 3

Redoublement	Oui	Non	Total	PACES	DFGSM2	DFGSM3	DFASM1	DFASM2	DFASM3
N	18	10	28	14	2	1	2	2	2
%	64 %	36 %	100 %	50 %	7 %	4 %	7 %	7 %	7 %

3.5. Description des résultats du LEC-5 par cluster

Exposition :1 : cela m'est arrivé; 2 : j'en ai été témoin; 3 : Je l'ai appris; 4 : fait partie de mon travail; 5 : incertain; 6 : ne s'applique pas à moi.

Tableau 5. LEC pour le cluster 1

Évènement	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**Total exposés**	**% exposés**	**Total répondants**
Catastrophe naturelle	8	0	4	0	1	33	13	28,3	46
Incendie, explosion	1	2	9	0	0	34	12	26,1	46
Accident de la route	11	10	8	1	0	16	30	65,2	46
Accident grave de travail, à domicile, pendant des loisirs	1	1	9	7	2	26	20	43,5	46
Exposition à une substance toxique	0	2	3	3	1	37	9	19,6	46
Agression physique	6	3	7	4	0	26	20	43,5	46
Attaque à main armée	3	2	4	5	0	32	14	30,4	46
Agression sexuelle	4	3	2	6	0	31	15	32,6	46
Autre expérience sexuelle non-désirée et désagréable (abus sexuel dans l'enfance)	2	3	1	7	0	33	13	28,3	46
Participation à un conflit armé ou présence dans une zone de guerre	0	1	4	2	0	39	7	15,2	46
Captivité	0	1	0	0	0	45	1	2,2	46
Maladie ou blessure mettant la vie en danger	3	8	8	6	0	21	25	54,3	46
Souffrance humaine intense	3	10	6	10	1	16	30	65,2	46
Mort violente	0	3	15	5	1	22	24	52,2	46
Mort subite et inattendue d'un proche	9	2	10	4	0	21	25	54,3	46
Blessure grave, dommage ou mort causée par vous à quelqu'un	1	2	0	0	1	42	4	8,7	46
Autre expérience stressante	4	0	0	0	0	42	4	8,7	46

Dans le cluster 1, une personne (2,2%) n'avait pas été exposée à un événement traumatique.
Le taux d'exposition à un événement traumatique dans le cluster 1 était donc de 97,8%.

Tableau 6. LEC-5 pour le cluster 2

Évènement	1	2	3	4	5	6	Total exposés	% exposés	Total répondants
Catastrophe naturelle	1	0	2	0	0	15	3	16,7	18
Incendie, explosion	2	1	1	1	0	13	5	27,8	18
Accident de la route	5	1	2	2	0	8	10	55,6	18
Accident grave de travail, à domicile, pendant des loisirs	0	0	2	2	0	14	4	22,2	18
Exposition à une substance toxique	0	0	0	1	0	17	1	5,6	18
Agression physique	1	0	3	1	0	13	5	27,8	18
Attaque à main armée	0	0	0	1	0	17	1	5,6	18
Agression sexuelle	0	0	4	2	0	12	6	33,3	18
Autre expérience sexuelle non-désirée et désagréable (abus sexuel dans l'enfance)	0	0	2	1	0	15	3	16,7	18
Participation à un conflit armé ou présence dans une zone de guerre	0	0	1	0	0	17	1	5,6	18
Captivité	0	0	0	0	0	18	0	0,0	18
Maladie ou blessure mettant la vie en danger	0	1	2	2	0	13	5	27,8	18
Souffrance humaine intense	0	1	2	3	0	12	6	33,3	18
Mort violente	0	1	4	2	0	11	7	38,9	18
Mort subite et inattendue d'un proche	1	0	1	2	0	14	4	22,2	18
Blessure grave, dommage ou mort causée par vous à quelqu'un	1	0	0	1	0	16	2	11,1	18
Autre expérience stressante	0	0	0	0	0	18	0	0,0	18

Dans le cluster 2, trois personnes (10,7%) n'avaient pas été exposées à un événement traumatique.

Le taux d'exposition à un événement traumatique dans le cluster 2 était de 89,3%.

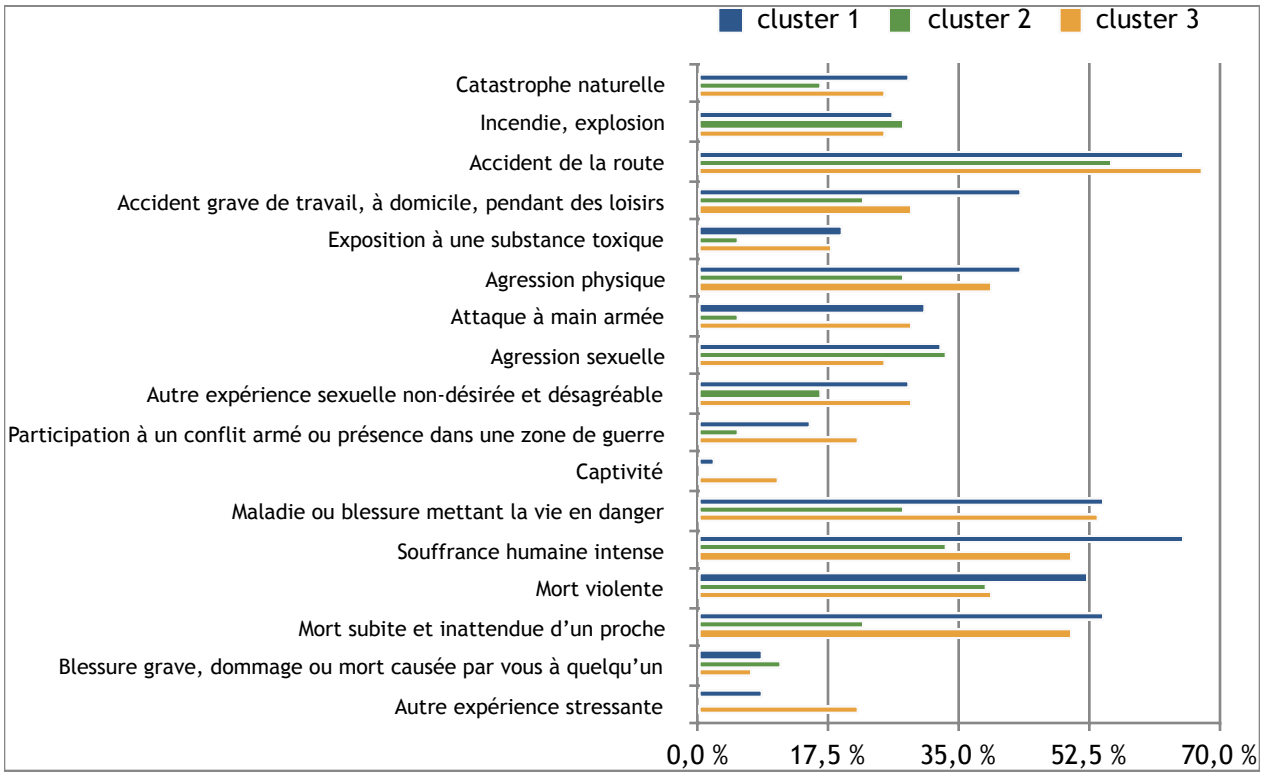
Tableau 7. LEC-5 pour le cluster 3

Évènement	1	2	3	4	5	6	Total exposés	% exposés	Total répondants
Catastrophe naturelle	3	1	3	0	0	21	7	25,0	28
Incendie, explosion	0	5	2	0	0	21	7	25,0	28
Accident de la route	4	6	7	2	0	9	19	67,9	28
Accident grave de travail, à domicile, pendant des loisirs	1	1	3	3	0	20	8	28,6	28
Exposition à une substance toxique	0	2	1	2	0	23	5	17,9	28
Agression physique	6	1	3	0	1	17	11	39,3	28
Attaque à main armée	2	1	3	1	1	20	8	28,6	28
Agression sexuelle	0	0	4	3	0	21	7	25,0	28
Autre expérience sexuelle non-désirée et désagréable (abus sexuel dans l'enfance)	1	0	3	3	1	20	8	28,6	28
Participation à un conflit armé ou présence dans une zone de guerre	0	0	6	0	0	22	6	21,4	28
Captivité	0	0	3	0	0	25	3	10,7	28
Maladie ou blessure mettant la vie en danger	1	7	2	5	0	13	15	53,6	28
Souffrance humaine intense	1	7	0	6	0	14	14	50,0	28
Mort violente	0	0	8	2	1	17	11	39,3	28
Mort subite et inattendue d'un proche	5	1	4	1	3	14	14	50,0	28
Blessure grave, dommage ou mort causée par vous à quelqu'un	0	0	1	1	0	26	2	7,1	28
Autre expérience stressante	4	0	1	1	0	22	6	21,4	28

Dans le cluster 3, deux personnes (7,1%) n'avaient pas été exposées à un événement traumatique.
Le taux d'exposition à un événement traumatique dans le cluster 3 était de 92,9%.

Dans la population étudiée, au total, six personnes (6,5%) n'avaient pas été exposées à un événement traumatique.
Le taux d'exposition à au moins un événement traumatique dans la population étudiée était de 93,5%.

Figure 2. Fréquence d'exposition aux traumatismes selon les clusters



Dans la population étudiée, les événements traumatisants les plus fréquents étaient les accidents de la route (64,1%), l'exposition à une souffrance humaine intense (54,3%), l'exposition à une maladie ou à une blessure mettant la vie en danger (48,3%), la mort subite ou inattendue d'un proche (46,7%), l'exposition à une mort violente (45,7%).

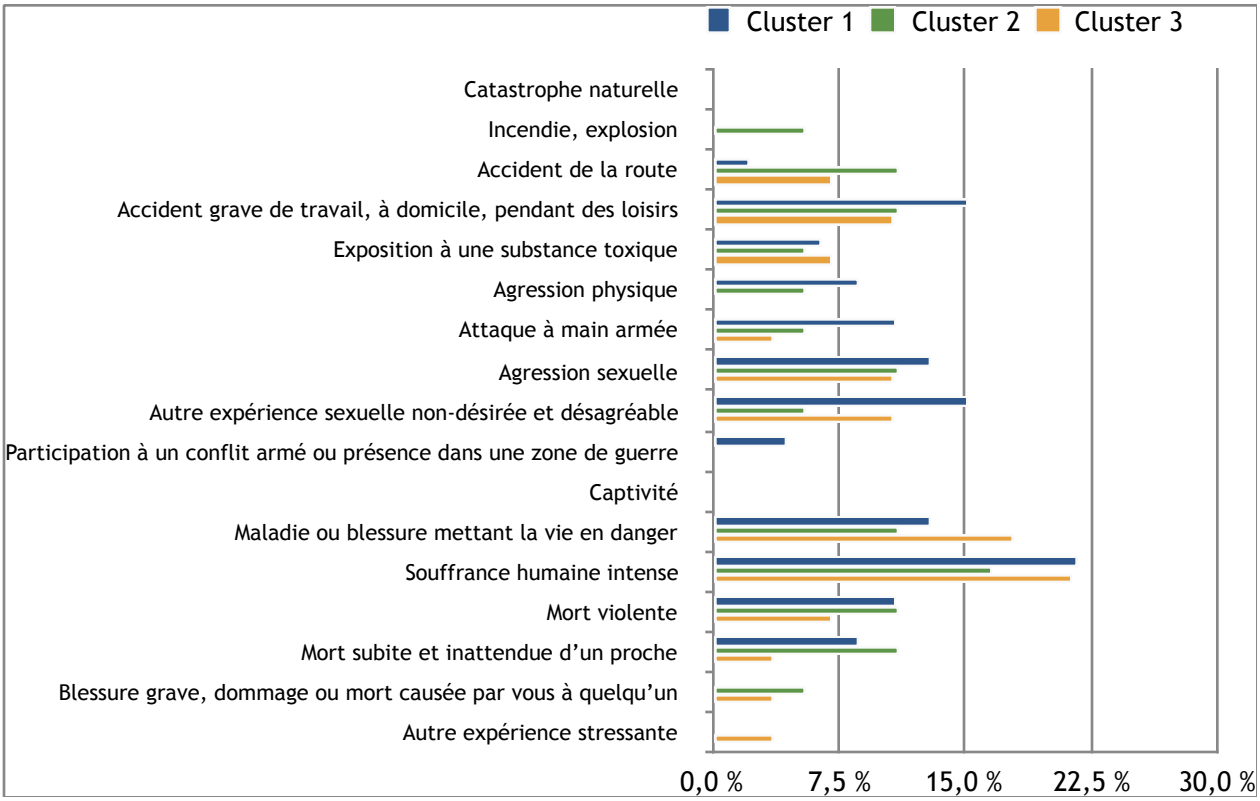
Dans le cluster 1, les événements traumatisants les plus fréquents étaient les accidents de la route (65,2%), l'exposition à une souffrance humaine intense (65,2%), l'exposition à une maladie ou à une blessure mettant la vie en danger (54,3%), la mort subite ou inattendue d'un proche (54,3%), l'exposition à une mort violente (52,2%).

Dans le cluster 2, les événements traumatisants les plus fréquents étaient les accidents de la route (55,6%), l'exposition à une mort violente (38,9%), l'exposition à une souffrance humaine intense (33%), l'exposition à une maladie ou à une blessure mettant la vie en danger (27,8%), la mort subite ou inattendue d'un proche (22,2%).

Dans le cluster 3, les événements traumatisants les plus fréquents étaient les accidents de la route (67,9%), l'exposition à une maladie ou à une blessure mettant la vie en danger (53,6%), l'exposition à une souffrance humaine intense (50%), la mort subite ou inattendue d'un proche (50%), l'exposition à une mort violente (39,3%).

A noter que chaque cluster était statistiquement différent (p<0,05, test du Khi2) des autres pour chaque exposition sauf pour l'exposition « blessure grave, dommage ou mort causé par vous à quelqu'un ».

Figure 3. Fréquence d'exposition aux événements traumatiques au travail en fonction des clusters



Dans la population étudiée, les événements traumatisants les plus fréquents au travail étaient l'exposition à une souffrance humaine intense (20,7%), l'exposition à une maladie ou blessure mettant la vie en danger (14,1%), l'exposition à un accident grave de travail, à domicile ou pendant des occupations de loisirs (13%), les agressions sexuelles (viol, tentative de viol, 12%), les autres expériences sexuelles non désirées et désagréables (abus sexuel dans l'enfance, 12%).

Dans le cluster 1, les événements traumatisants les plus fréquents au travail étaient l'exposition à une souffrance humaine intense (21,7%), les autres expériences sexuelles non désirées et désagréables (abus sexuel dans l'enfance, 15,2%) l'exposition à un accident grave de travail, à domicile ou pendant des occupations de loisirs (15,2%), les agressions sexuelles (viol, tentative de viol, 13%), l'exposition à une maladie ou blessure mettant la vie en danger (113%).

Dans le cluster 2, les événements traumatisants les plus fréquents au travail étaient l'exposition à une souffrance humaine intense (16,2%), l'exposition à une maladie ou blessure mettant la vie en danger (11,1%), l'exposition à un accident grave de travail, à domicile ou pendant des occupations de loisirs (11,1%), les agressions sexuelles (viol, tentative de viol, 11,1%), les autres expériences sexuelles non désirées et désagréables (abus sexuel dans l'enfance, 5,6%).

Dans le cluster 3, les événements traumatisants les plus fréquents au travail étaient l'exposition à une souffrance humaine intense (21,4%), l'exposition à une maladie ou blessure mettant la vie en danger (17,9%), l'exposition à un accident grave de travail, à domicile ou pendant des occupations de loisirs (10,7%), les agressions sexuelles (viol, tentative de viol, 10,7%), les autres expériences sexuelles non désirées et désagréables (abus sexuel dans l'enfance, 10,7%).

Tableau 8. Résultats des Anovas sur les scores du YSQ-S3 standardisés, les scores OCEAN, l'IRI et le MBI en fonction des 3 clusters dans un échantillon de 92 étudiants en TCEM1

	Cluster 1 N=46 (50,0%)		cluster 2 N=18 (19,6%)		cluster 3 N=28 (30,4%)		Total N=92 (100,0%)			
Variable	M	DS	M	DS	M	DS	M	DS	p	F
Age	25,6^{ab}	0,3	25,2^{cd}	0,4	25,6^{ef}	0,4	25,5	1,9	0,700	0,36
En couple	0,6^{ab}	1,0	0,8^{cd}	0,4	0,5^{ef}	0,5	0,6	0,5	0,256	1,38
Redoublement	0,3^{ab}	0,4	0,4^{cd}	0,5	0,5^{ef}	0,5	0,4	0,48	0,110	2,24
O	34,9^{ab}	7,0	28,0^{ac}	12,0	34,9^{cd}	9,0	33,6	9,1	0,015	4,4
C	34,2^{ab}	5,9	30,4^{cd}	12,3	31,6^{ef}	6,8	32,7	7,8	0,148	1,9
E	27,4^{ab}	7,0	22,6^{cd}	9,8	20^{af}	6,4	24,2	8,0	0,000	9,19
A	42,5^{ab}	4,3	39,3^{cd}	14,7	38^{ef}	8,0	40,5	8,5	0,073	2,7
N	22,8^{ab}	6,5	15,4^{ac}	8,3	22,8^{cd}	7,7	21,4	7,8	0,000	7,57
FS	17,5^{ab}	6,5	10,8^{ac}	5,1	16,7^{cd}	6,8	15,9	6,8	0,000	7,71
PT	18,6^{ab}	4,5	17,3^{cd}	7,9	17,5^{ef}	5,5	18,0	5,6	0,590	0,54
EC	19,7^{ab}	4,0	16,8^{cd}	6,4	19^{ef}	5,4	18,9	5,1	0,140	2
PD	11,8^{ab}	5,5	9,4^{cd}	5,3	12^{ef}	5,6	11,4	5,5	0,240	1,43
Ec	36,1^{ab}	9,1	28^{ac}	12,1	34,2^{de}	10,1	33,9	10,4	0,017	4,21
Ee	31,4^{ab}	7,7	26,3^{ac}	11,2	31^{de}	8,3	30,3	8,8	0,016	4,35
SPI 11	15^{ab}	4,0	8,7^{ac}	4,3	16,7^{cd}	4,9	14,3	5,2	0,000	19,6
SPI 12	9^{ab}	2,6	6,1^{ac}	3,0	17,9^{bc}	3,9	11,1	5,6	0,000	99,4
SPI 13	13,6^{ab}	3,3	6,7^{ac}	3,2	17,4^{bc}	3,6	13,4	5,0	0,000	53,8
SPI 18	12,7^{ab}	3,6	6,2^{ac}	2,7	15^{bc}	4,3	12,1	4,8	0,000	33
EE	14,2^{ab}	6,5	9,1^{cd}	3,6	19^{ad}	8,2	14,8	8,2	0,000	9,6
DEP	6,6^{ab}	4,1	5,3^{cd}	7,1	8,9^{ce}	5,3	7,1	4,6	0,300	3,7
AP	34,5^{ab}	6,6	33,2^{cd}	9,1	33,3^{ef}	8,4	33,9	7,6	0,769	0,3
PDI	15^{ab}	11,5	7,3^{cd}	7,7	9^{ef}	8,6	11,7	10,5	0,013	4,5

3.6. Description des paramètres démographiques en fonction des clusters

Il n'existait pas de différence significative entre les clusters pour :

- l'âge avec une moyenne totale à 25,5 ans,
- le redoublement au cours des études de médecine avec un taux de redoublement total de 64%,
- le fait de vivre en couple ou non avec un total de 62% de personnes étant en couple.

La répartition entre les 3 clusters était donc homogènes pour ces paramètres.

3.7. Recherche de corrélation entre profil de personnalité et résultats aux différents tests

Le groupe 1 est statistiquement différent ($p<0,05$) :

- Du groupe 2 pour Abnégation, Surcontrôle Emotionnel, Idéaux Exigeants, Punition (SPI plus présents), il présente une plus grande ouverture et un plus grand Névrosisme, une Ec plus forte, un PDI plus élevé.
- Du groupe 3 pour Surcontrôle Emotionnel, Idéaux Exigeants, Punition (SPI moins présents), une Extraversion plus élevée, un EE moins élevé.

Le groupe 2 est statistiquement différent ($p<0,05$) :

- Du groupe 1 pour Abnégation, Surcontrôle Emotionnel, Idéaux Exigeants, Punition (SPI moins présents), une Ouverture et un Névrosisme moins élevés, une Ec moins élevée; un PDI moins élevé.
- Du groupe 3 pour Abnégation, Surcontrôle Emotionnel, Idéaux Exigeants, Punition (SPI moins présents), une Ouverture et un Névrosisme moins élevés, un EE et une DEP moins élevés.

Le groupe 3 est statistiquement différent ($p<0,05$) :

- Du groupe 1 pour Surcontrôle Emotionnel, Idéaux Exigeants, Punition (SPI plus présents), une Extraversion moins élevée, un EE plus élevé.
- Du groupe 2 pour Abnégation, Surcontrôle Emotionnel, Idéaux Exigeants, Punition (SPI plus présents), une Ouverture et un Névrosisme plus élevés, un EE et une DEP plus élevés.

3.8. Comparaison des moyennes des scores à l'IRI, au MBI, aux SPI 11, 12, 13, 18, au Big Five et au PDI ; entre les premiers répondeurs et ceux avec relance

Tableau 11. Comparaison des moyennes des scores à l'IRI, au MBI, aux SPI 11, 12, 13, 18, au BFI-Fr et au PDI ; entre les premiers répondeurs et ceux avec relance.

	1er répondeurs N = 41		**Répondeurs après relance N = 51**		
	M	**DS**	**M**	**DS**	**p**
FS	16,5	7,4	15,5	6,2	0,46
PT	18,2	5,8	17,8	5,4	0,75
EC	20,1	5,5	18	4,7	0,051
PD	10,9	5	11,8	5,9	0,44
Ec	34,8	11,6	33,3	9,4	0,52
Ee	31	8,8	29,7	8,9	0,50
EE	14,8	8,3	14,9	8,2	0,95
DEP	6,9	4,8	7,2	4,6	0,83
AP	33,9	7,6	34	7,7	7,6
S11	15,3	6	13,5	4,3	0,12
S12	10,9	5,6	11,4	5,6	0,65
S13	13,3	5,2	13,4	4,8	0,91
S18	12,6	5,1	11,7	4,5	0,36
O	78,6	22,4	76,4	20	0,62
C	87	24,5	85,5	25,2	0,78
E	57,5	14,6	59,3	14,8	0,58
A	90,5	28,4	87,2	23,6	0,56
N	62,9	19,2	63,5	19	0,89
PDI	12,5	12	11,5	9,5	0,65

Les premiers répondeurs représentaient 44,6% de l'ensemble des 92 participants.

Aucune différence significative ($p>0,05$, test de student) n'a été retrouvée pour les scores à l'IRI, au MBI, aux SPI 11, 12, 13, 18 au Big Five et au PDI entre les premiers répondeurs et les répondeurs après relance.

4/ DISCUSSION

4.1. Généralités

Cette étude a pour but de rechercher l'influence des SPI sur le BO, l'empathie et le TSPT.

4.2. Limites et biais de l'enquête

Cette étude introduit différents biais pouvant mener à une mauvaise interprétation des résultats.

4.2.1. Puissance/ taux de participation

Le taux de participation sur la promotion de TCEM1 est important (83,6%). Cependant, une seule promotion ne peut être représentative de toute la population française d'internes.

4.2.2. Biais de sélection

Il ne semble pas y avoir de biais de sélection étant donné que la participation à l'étude est forte.

4.2.3. Biais lié à l'interprétation des résultats

Cette étude montre des corrélations entre différentes personnalités et l'empathie et le risque de BO, cependant, on ne peut pas conclure à un lien de causalité.

4.2.4. Biais de déclaration

Malgré l'anonymat et l'utilisation de questionnaires validés, il peut exister un biais de déclaration. En effet, il existe une part de subjectivité dans la réponse aux différents questionnaires.
Le PCL-5, qui permet d'évaluer la présence d'un TSPT, n'a été rempli que par 17,4% de la population étudiée. Devant le faible taux de réponse et donc de puissance, nous avons décidé de ne pas l'analyser.
Le PTGI, qui nécessite un TPST pour être analysé avec pertinence, n'a donc pas été pris en compte dans l'analyse statistique de l'étude.
Afin de remédier à ce biais, il faudrait que la population étudiée soit plus importante.

4.2.5. Biais de confusion

Plusieurs biais de confusion n'ont pas été pris en compte (culture, niveau socio-économique des parents, religion) et peuvent potentiellement limiter la pertinence de l'analyse des résultats.

4.2.6. Biais de mesure

Le YSQ-S3 permet de retrouver des SPI prédominants chez une personne. Lors du recueil du questionnaire, on s'intéresse aux scores élevés (généralement supérieurs à trois) des SPI. Chaque SPI est évalué par cinq items côtés de 1 à 6.
Pour qu'un SPI soit prédominant, on pourrait s'attendre à des scores supérieurs à 20.
Or dans notre étude, les moyennes des scores les plus élevés ne dépassent pas 15. Nous avons donc des groupes avec des SPI prédominants par rapport aux autres, sans que ceux-ci semblent pathologiques.

4.3. Analyse des résultats

4.3.1. Taux d'exposition à un événement traumatique

Notre étude retrouve un taux d'exposition de 93,5% à au moins un événement traumatique, un résultat proche d'une étude récente qui retrouvait une exposition de 97% chez les étudiants en médecine (24).

Selon Benjet (16), 70,4% de la population mondiale a vécu un événement traumatique. Il semble donc ressortir que la population des étudiants en médecine est plus exposée que la population mondiale. Cette constatation a déjà été faite (24) avec un taux d'exposition à 97% chez des étudiants en médecine.

Dans notre étude, l'événement traumatique, « fait partie de mon travail », le plus présent dans chaque cluster est « souffrance humaine intense » avec, au total, 20,6% de la population exposée.

Les professionnel de santé sont régulièrement et fréquemment soumis à ce type d'exposition, ce qui peut en partie expliquer un plus fort taux d'exposition à un événement traumatique. Cette constatation serait à confirmer à travers d'autres études, notamment pour d'autres corps de métiers.

4.3.2. YSQ-S3

Pour chaque cluster, il existe une différence significative pour les SPI Surcontôle Emotionnel, Idéaux Exigeants et Punition.

Il est intéressant de noter que ces 3 SPI font partis d'un seul est même domaine (sur 5 domaines de SPI), celui de la « sur-vigilance et inhibition» (SPI Négativité / Pessimisme, Surcontrôle Emotionnel, Idéaux Exigeant, Punition). Selon Young (41), les patients qui appartiennent à ce domaine, répriment l'expression spontanée de leurs sentiments et de leurs impulsions. Le problème principal est le contrôle exagéré des réactions, des sentiments et des choix, pour éviter les erreurs ou pour maintenir des règles personnelles rigides concernant la conduite et la performance, souvent aux dépens d'autres aspects de la vie : plaisirs, loisirs, amis ou au détriment de la santé. L'origine typique est une enfance sans joie, retenue et stricte, dans laquelle le contrôle de soi et le déni de soi-même l'emportaient sur la spontanéité et le plaisir. […]. Ces patients sont souvent pessimistes et préoccupés, ils considèrent que tout dans leur vie pourrait se désagréger s'ils ne se montraient pas toujours vigilants et attentifs.

4.3.3. PDI

Le cluster 1 présente des scores de PDI statistiquement différents ($p<0,05$) au cluster 2. Ce groupe est marqué par les SPI Abnégation, Surcontrôle Emotionnel, Idéaux Exigeants plus présents que dans le cluster 2.

Cependant, il n'y a pas de différence significative pour le PDI entre le cluster 1 et 3, alors que le cluster 3 est celui qui a les 4 SPI les plus élevés.

Les SPI ne semblent donc pas intervenir pour une majoration de la détresse péri-traumatique.

4.3.4. IRI

Le cluster 1 présente des scores d'Ec significativement plus élevé ($p<0,05$) que le cluster deux. Les 4 SPI du cluster 1 sont plus élevés que ceux du cluster 2.

Cependant, les SPI Surcontrôle Emotionnel, Idéaux Exigeants et Punition sont plus élevés dans le cluster 3 que dans le cluster 1 et il n'y a pas de différence significative pour l'Abnégation entre le cluster 1 et 3.

Dans notre étude, les SPI ne semblent donc pas intervenir sur l'empathie, contrairement à une autre étude (44) qui retrouve une diminution d'empathie lors de la présence des SPI.

4.3.5. Modèle des cinq grands facteurs de personnalité

Le cluster 1 est significativement différent ($p<0,05$) du cluster 2 pour Ouverture, Extraversion et Névrosisme, ils sont plus élevés.

Le cluster 3 est significativement différent ($p<0,05$) du cluster 2 pour Ouverture et Névrosisme, ils sont plus élevés.

La conclusion qui semble ressortir de ces résultats est que la présence des SPI Surcontrôle Emotionnel, Idéaux Exigeants et Punition sont corrélés à une Ouverture et un Névrosisme plus élevés.

Plusieurs études ont retrouvé un lien entre la présence de SPI et Névrosisme (42, 43).

4.3.6. MBI

Le cluster 3 est significativement différent ($p<0,05$) du cluster 1 et 2 pour l'EE, il est plus élevé avec une moyenne respectivement à 19 (cluster 3, BO modérée) contre 14,2 (cluster 1, BO bas) et 9,1 (cluster 2, BO bas).

Le cluster 3 est significativement différent ($p<0,05$) du cluster 2 pour la DEP, il est plus élevé avec une moyenne à 8,9 (BO modéré) contre 5,3 (BO modéré).

La présence des quatre SPI semble donc intervenir dans la survenue d'un EE et d'une DEP.

Ce résultat est concordant avec une autre étude (14) menée chez des psychologues qui montrait que les deux SPI majoritaires étaient idéaux exigeants et abnégation. Dans ces SPI, il y avait un fort taux d'épuisement professionnel, avec 18,3% dans la fourchette haute et 29,6% dans la fourchette modérée d'EE.

4.3.7. Comparaison des moyennes des scores à l'IRI, au MBI, aux SPI 11, 12, 13, 18, au BFI-Fr et au PDI ; entre les premiers répondeurs et ceux avec relance

Aucune différence significative ($p>0,05$, test de student) n'a été retrouvée pour les scores à l'IRI, au MBI, aux SPI 11, 12, 13, 18 et au PDI entre les premiers répondeurs et les répondeurs après relance.

Les premiers répondeurs était donc représentatifs de la population étudiée et le fait d'avoir des SPI présents ou un SEP ne permet pas de préjuger de « la rapidité » de réponse.

4.4. Moyens proposés

Au vue de ces résultats, il serait intéressant de proposer un suivi psychologique adapté aux étudiants présentant des SPI.

Selon Young, les SPI se créent dans l'enfance. Le dépistage de ces SPI pourrait donc être réalisé précocement dans le cursus médical afin d'éviter la survenue d'un SEP.

Chaque étudiant présentant des SPI pourrait avoir un tuteur (médecin généraliste ou psychiatre) qui le suivrait tout au long de sa scolarité, afin de l'aider dans la gestion de situations difficiles.

5/ CONCLUSION

Depuis plusieurs années, le syndrome d'épuisement professionnel est de plus en plus médiatisé, notamment chez les soignants. Seulement, peu d'actions ont été entreprises afin de diminuer ce risque.

Cette étude retrouve que plus les SPI Sur-contrôle Emotionnel, Idéaux Exigeants et Punition sont élevés, plus l'Ouverture et le Névrosisme sont élevés, ainsi que l'Epuisement Emotionnel et une Dépersonnalisation élevés.

Nous n'avons pas pu mettre en évidence de lien entre les SPI et la survenue d'un TSPT.

En effet, malgré une forte exposition aux événements traumatiques, le PCL-5 n'a été rempli que par une petite partie de la population étudiée. Or ce questionnaire est nécessaire pour dépister un TPST.

Par ailleurs, aucun lien entre les SPI et l'empathie n'a pu être mis en évidence, alors qu'une étude (44) retrouve une diminution d'empathie lors de la présence des SPI.

On peut noter que le le fait d'avoir des SPI présents ou un SEP ne permet pas de préjuger de « la rapidité » de réponse.

Une étude de plus grande ampleur pourrait permettre de confirmer nos hypothèses mais aussi de mettre en évidence un lien en la présence des SPI et empathie, ainsi que sur la survenue de TSPT.

Un dépistage des étudiants ayant des SPI, présents par définition dès l'enfance, pourrait être envisager afin de les accompagner tout au long de leurs études et diminuer ainsi la survenue d'un SEP.

6/ BIBLIOGRAPHIE

1. Préface de La thérapie des schémas, Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko et Marjorie E. Weishaar, p. 15-16.

2. Saddichha, Sahoo, Ajay Kumar, et Nirmala Pradhan. Cognitive schemas among mental health professionals: Adaptive or maladaptive? Journal of Research in Medical Sciences : The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences 17, nº 6 (juin 2012): 523‑26.

3. The Big-Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives. Oliver P. John and Sanjay Srivastava. University of California at Berkeley. https://pages.uoregon.edu/sanjay/pubs/bigfive.pdf.

4. Kansoun, Ziad, Laurent Boyer, Marianne Hodgkinson, Virginie Villes, Christophe Lançon, et Guillaume Fond. « Burnout in French physicians: A systematic review and meta-analysis ». Journal of Affective Disorders 246 (1 mars 2019): 132‑47. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.12.056.

5. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job Burnout. Annu.rev Psychol. 2001;52:397-422

6. Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory. (3rd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

7. Maslach, C et col. (2006). Burn-out : l'épuisement professionnel. Presses du Belvédère.

8. Bamber, Martin, et Rachel McMahon. Danger—Early Maladaptive Schemas at Work!: The Role of Early Maladaptive Schemas in Career Choice and the Development of Occupational Stress in Health Workers. Clinical Psychology & Psychotherapy 15, nº 2 (2008): 96‑112. https://doi.org/10.1002/cpp.564.

9. Simpson, Susan, Gabriella Simionato, Matthew Smout, Michiel F. van Vreeswijk, Chris Hayes, Christina Sougleris, et Corinne Reid. Burnout amongst Clinical and Counselling Psychologist: The Role of Early Maladaptive Schemas and Coping Modes as Vulnerability Factors. Clinical Psychology & Psychotherapy 26, nº 1 (2019): 35‑46. https://doi.org/10.1002/cpp.2328.

10. Bakker, Arnold B., Karen I. van der Zee, Kerry A. Lewig, et Maureen F. Dollard. The Relationship Between the Big Five Personality Factors and Burnout: A Study Among Volunteer Counselors. Journal of Social Psychology 146, nº 1 (février 2006): 31–50. https://doi.org/10.3200/SOCP.146.1.31-50.

11. Zenasni, F., Boujut, E., Bluffel du Vaure, C., Catu-Pinault, A., Tavani, J. L., Rigal, L., … Sultan, S. (2012). Development of a French-language version of the Jefferson scale of physician empathy and association with practice characteristics and burnout in a sample of general practitioners. International Journal of Person-Centered Medicine, 2, 759–766. doi:10.5750/ijpcm.v2i4.295.

12. Lamothe, Martin, Emilie Boujut, Franck Zenasni, et Serge Sultan. To Be or Not to Be Empathic: The Combined Role of Empathic Concern and Perspective Taking in Understanding Burnout in General Practice. BMC Family Practice 15 (2014): 15.

13. Rogers C. On becoming a person. A therapist's view of psychotherapy. Boston: Mifflin; 1961 : 284

14. Davis MW. A Multidimensional Approach to Individual Differences in Empathy. JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology. 1980 ;10:1-85.

15. Decety, Jean, et Philip L. Jackson. The Functional Architecture of Human Empathy. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews 3, nº 2 (juin 2004): 71–100. https://doi.org/10.1177/1534582304267187.

16. Benjet C, Bromet E, Karam EG, Kessler RC, McLaughlin KA, Ruscio AM, et al. The epidemiology of traumatic event exposure worldwide: results from the World Mental Health Survey Consortium. Psychological Medicine. janv 2016;46(02):327–43.

17. Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson CB. Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry. déc 1995;52(12): 1048–60.

18. D.G. Kilpatrick, H.S. Resnick, M.E. Milanak, M.W. Miller, K.M. Keyes, M.J. Friedman National estimates of exposure to traumatic events and PTSD prevalence using DSM-IV and DSM-5 criteria J Trauma Stress, 26 (5) (Oct 2013), pp. 537-547.

19. Jackson T, Provencio A, Bentley-Kumar K, Pearcy C, Cook T, McLean K, et al. PTSD and surgical residents: Everybody hurts... sometimes. The American Journal of Surgery. 1 déc 2017;214(6):1118–24.

20. Ong YZ, Siddiqui S, John S, Chen Z, Chang S. The Prevalence of Post-Traumatic Stress Disorder in Intensive Care Unit Staff and the Common Coping Strategies Used. Ann Acad Med Singap. mai 2016;45(5):215‑8.

21. Breslau N, Davis GC, Andreski P, Peterson E. Traumatic events and posttraumatic stress disorder in an urban population of young adults. Arch Gen Psychiatry. mars 1991;48(3):216‑22

22. Harding, Hilary G., Erin E. Burns, et Joan L. Jackson. Identification of Child Sexual Abuse Survivor Subgroups Based on Early Maladaptive Schemas: Implications for Understanding Differences in Posttraumatic Stress Disorder Symptom Severity. Cognitive Therapy and Research 36, nº 5 (octobre 2012): 560‑75. https://doi.org/10.1007/s10608-011-9385-8

23. Relationship of early-life trauma, war-related trauma, personality traits, and PTSD symptom severity : a retrospective study on female civilian victims of war: European Journal of Psychotraumatology: Vol 7, No 1. Consulté le 25 juillet 2019. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/ejpt.v7.30964.

24. SENOTIER Chloé, Profils de personnalité et développement du trouble de stress post-traumatique chez les étudiants en Médecine de la Faculté de Poitiers, Thèse de Doctorat d'Université, Médecine Générale, Poitiers, 2019.

25. Palgi, Sharon, Ehud Klein, et Simone Shamay-Tsoory. « The role of oxytocin in empathy in PTSD ». Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 9, nº 1 (janvier 2017): 70‑75. https://doi.org/10.1037/tra0000142.

26. Bouvard, Martine, Anne Denis, et Jean Luc Roulin. Psychometric Properties of the French Version of the Young Schema Questionnaire - Short Form 3 (YSQ–S3). The Spanish Journal of Psychology 21 (2018): E57. https://doi.org/10.1017/sjp.2018.66.

27. John OP. The "Big Five" factor taxonomy: Dimensions of personality in the natural language and in questionnaires. In : Pervin LA, editors. Handbook of personality: Theory and research. New York : Guilford press; 1990. p.66–100.

28. Plaisant, O., S. Srivastava, G.A. Mendelsohn, Q. Debray, et O.P. John. Relations entre le Big Five Inventory français et le manuel diagnostique des troubles mentaux dans un échantillon clinique français. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 163, nº 2 (mars 2005): 161‑67. https://doi.org/10.1016/j.amp.2005.02.002.

29. Plaisant, O., R. Courtois, C. Réveillère, G.A. Mendelsohn, et O.P. John. Validation par analyse factorielle du Big Five Inventory français (BFI-Fr). Analyse convergente avec le NEO-PI-R. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 168, nº 2 (mars 2010): 97−106. https://doi.org/10.1016/j.amp.2009.09.003.

30. Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M.P. (1996). Mastach Burnout Inventory (3rd ed.). Palo Alto, CA : Consulting Psychologists Press.

31. MH Davis. Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 1983 v.44:1 p.113-126.

32. Gilet, Anne-Laure, Nathalie Mella, Joseph Studer, Daniel Grühn, et Gisela Labouvie-Vief. Assessing dispositional empathy in adults: A French validation of the Interpersonal Reactivity Index (IRI). Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement 45, nº 1 (janvier 2013): 42−48. https://doi.org/10.1037/a0030425.

33. Life Events Checklist for DSM-5 (LEC-5) - PTSD: National Center for PTSD. General Information. Consulté le 13 juin 2019. https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/te-measures/life_events_checklist.asp.

34. Weathers, F.W., Blake, D.D., Schnurr, P.P., Kaloupek, D.G., Marx, B.P. et Keane, T.M. (2013). Liste de contrôle des événements de la vie pour le DSM-5 (LEC-5). Instrument disponible auprès du Centre national de l'ESPT, à l'adresse www.ptsd.va.gov.

35. Gray, M., Litz, B., Hsu, J. et Lombardo, T. (2004). Propriétés psychométriques de la liste de contrôle des événements de la vie. (PDF) Assessment, 11, 330-341. Numéro d'identification: 10.1177 / 1073191104269954 ID DE PILOTES: 26825.

36. Brunet, A., Weiss, D.S., Metzler, T.J., et al. (2001). The Peritraumatic Distress Inventory: A proposed Measure of PTSD criterion A2. American Journal of Psychiatry, 158, 1480-1485.

37. Jehel, L., Brunet, A., Paterniti, S., et al. (2005). Validation of the French version of the Peritraumatic Distress Inventory. Canadian Journal of Psychiatry, 50, 67-71.

38. PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) - PTSD: National Center for PTSD. General Information. Consulté le 23 janvier 2019. https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/adult-sr/ptsd-checklist.asp.

39. Tedeschi, R.G. and Calhoun, L.G. (1996) The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring The Positive Legacy of Trauma. Journal of Traumatic Stress, 9, 455-471. http://dx.doi.org/10.1002/jts.2490090305.

40. Cadell, Susan, Eliana Suarez, et David Hemsworth. Reliability and Validity of a French Version of the Posttraumatic Growth Inventory. Open Journal of Medical Psychology 04, nº 02 (2015): 53–65. https://doi.org/10.4236/ojmp.2015.42006.

41. La thérapie des schémas, Jeffrey E; Young, Janet S. Klosko et Marjorie E. Weishaar, p. 42.

42. Muris, Peter. Maladaptive Schemas in Non-Clinical Adolescents: Relations to Perceived Parental Rearing Behaviours, Big Five Personality Factors and Psychopathological Symptoms. Clinical Psychology & Psychotherapy 13, nº 6 (2006): 405–13. https://doi.org/10.1002/cpp.506.

43. Briet, Gaëtan. Schémas précoces inadaptés et dimensions de la personnalité chez des adolescents consommateurs abusifs d'alcool. Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive 27 (1 octobre 2017). https://doi.org/10.1016/j.jtcc.2017.03.001.

44. Mirovic, Tijana, et Daniel Meskovic. Explaining Early Maladaptive Schemas (EMSS): Connections between EMS and basic personality dimensions, affective attachment styles and empathy. In Advances in Psychology Research, 45–81, 2017.

7/ ANNEXES

Annexe n°1 - QUESTIONNAIRE DES SCHÉMAS DE YOUNG (YSQ-S3)

Instructions

Vous allez trouver ci-dessous des affirmations qui pourraient être utilisées par une personne pour se décrire elle-même. Nous vous prions de lire chaque affirmation et d'évaluer dans quelle mesure elle constitue une bonne description de vous-même, **au cours de l'année passée**. Lorsque vous hésitez, basez votre réponse sur ce que vous ressentez **émotionnellement**, et non pas sur ce que vous pensez **rationnellement** être vrai pour vous.

Certains des items concernent vos relations avec vos parents ou vos relations sentimentales. Si certaines des personnes concernées sont décédées, veuillez répondre sur la base des relations que vous aviez avec elles lors de leur vivant. Si vous n'avez actuellement aucune relation sentimentale, mais que vous avez eu des partenaires dans le passé, veuillez répondre en tenant compte de votre partenaire important(e) le (la) plus récent(e).

Choisissez ensuite entre 1 et 6 la cote vous décrivant le mieux et entourez la.

<u>Échelle de cotation</u> :

1. Cela est complètement faux pour moi.
2. Le plus souvent faux pour moi.
3. Plutôt vrai que faux pour moi.
4. Assez vrai pour moi.
5. Le plus souvent vrai pour moi.
6. Me décrit parfaitement.

1. Je n'ai eu personne pour m'aider à grandir, pour partager son univers intérieur avec moi, ou qui se soucie profondément de tout ce qui m'arrive.	1	2	3	4	5	6
2.Je m'accroche aux gens dont je suis proche par peur qu'ils ne me quittent.	1	2	3	4	5	6
3. J'ai l'impression que les autres vont profiter de moi.	1	2	3	4	5	6
4. Je ne suis pas adapté(e).	1	2	3	4	5	6
5. Aucun homme ou femme que je désire ne pourrait m'aimer une fois qu'il(elle) aurait vu mes défauts.	1	2	3	4	5	6
6. Presque rien de ce que je fais au travail (ou à l'école) n'est aussi bon que ce que font les autres.	1	2	3	4	5	6
7. Je ne me sens pas capable de me débrouiller par moi-même dans la vie de tous les jours.	1	2	3	4	5	6

8. Il ne me semble pas possible d'échapper au sentiment que quelque chose de mauvais va bientôt se passer.	1	2	3	4	5	6
9. Je n'ai pas pu me séparer de ma mère ou de mon père comme semblent le faire les gens de mon âge.	1	2	3	4	5	6
10. Je pense que si je fais ce que je veux, je cours après les problèmes.	1	2	3	4	5	6
11. Je suis celui (celle) qui finit généralement par prendre soin des gens dont je suis proche.	1	2	3	4	5	6
12. Je suis trop gêné(e) pour exprimer des sentiments positifs aux autres (par ex. de l'affection, de l'intérêt).	1	2	3	4	5	6
13. Je dois être le(la) meilleur(e) dans presque tout ce que je fais, je ne peux pas accepter d'être le(la) deuxième.	1	2	3	4	5	6
14. Lorsque j'attends quelque chose des autres, j'ai beaucoup de difficulté à accepter un refus.	1	2	3	4	5	6
15. Il ne me semble pas possible de me discipliner pour terminer des tâches routinières ou ennuyeuses.	1	2	3	4	5	6
16. Posséder de l'argent et connaître des gens importants sont des choses qui me donnent de la valeur.	1	2	3	4	5	6
17. Même lorsque tout va bien, j'ai l'impression que ce ne sera que temporaire.	1	2	3	4	5	6
18. Si je fais une erreur, je mérite d'être puni(e).	1	2	3	4	5	6
19. Je n'ai personne pour me prendre dans ses bras, pour me donner de la chaleur et de l'affection.	1	2	3	4	5	6
20. J'ai tellement besoin des autres que j'ai peur de les perdre.	1	2	3	4	5	6
21. J'ai l'impression que je dois être sur mes gardes en présence des autres sinon ils me blesseront intentionnellement.	1	2	3	4	5	6
22. Je suis fondamentalement différent(e) des autres.	1	2	3	4	5	6
23. Aucune personne que je désire ne pourrait rester proche de moi si elle savait qui je suis réellement.	1	2	3	4	5	6
24. Je suis incompétent(e) quand il s'agit de réussir.	1	2	3	4	5	6
25. Je me considère comme une personne dépendante en ce qui concerne la vie de tous les jours.	1	2	3	4	5	6
26. J'ai l'impression qu'un désastre naturel, criminel, financier ou médical pourrait frapper à tout moment.	1	2	3	4	5	6
27. Mes parents et moi avons tendance à être sur-impliqués dans nos vies et nos problèmes réciproques.	1	2	3	4	5	6
28. Je sens que je n'ai pas d'autre choix que de me soumettre aux souhaits des autres, sinon ils exerceront des représailles ou me rejetteront d'une façon ou d'une autre.	1	2	3	4	5	6
29. Je suis quelqu'un de bon car je pense aux autres plus qu'à moi-même.	1	2	3	4	5	6
30. Je trouve embarrassant d'exprimer mes sentiments aux autres.	1	2	3	4	5	6
31. Je m'efforce de faire de mon mieux ; je ne peux pas me contenter d'être « assez bien ».	1	2	3	4	5	6
32. Je suis quelqu'un de spécial et je ne devrais pas avoir à accepter les restrictions auxquelles les autres doivent se soumettre.	1	2	3	4	5	6
33. Si je ne peux pas atteindre un but, je suis facilement frustré(e) et j'abandonne.	1	2	3	4	5	6
34. Mes réussites ont plus de valeur à mes yeux si les autres les remarquent.	1	2	3	4	5	6
35. S'il se produit quelque chose de bien, j'ai peur qu'il n'arrive ensuite quelque chose de mauvais.	1	2	3	4	5	6
36. Si je ne donne pas le meilleur de moi-même, je dois m'attendre à échouer.	1	2	3	4	5	6
37. Je n'ai jamais eu le sentiment que je représentais quelqu'un d'important pour quelqu'un d'autre.	1	2	3	4	5	6

38. Je crains que les gens dont je me sens proche ne me quittent ou ne m'abandonnent.	1	2	3	4	5	6
39. Ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un me trahisse.	1	2	3	4	5	6
40. Je suis à part ; je suis un(e) solitaire.	1	2	3	4	5	6
41. Je ne mérite pas l'amour, l'attention et le respect des autres.	1	2	3	4	5	6
42. La plupart des gens sont plus doués que moi en ce qui concerne le travail (ou l'école) et la réussite.	1	2	3	4	5	6
43. Je manque de bon sens.	1	2	3	4	5	6
44. J'ai peur d'être attaqué(e) physiquement par des gens.	1	2	3	4	5	6
45. Il est très difficile, pour mes parents et moi-même, de garder secrets, chacun pour soi, certains détails intimes, sans nous sentir trahis ou coupables.	1	2	3	4	5	6
46. Dans mes relations, je laisse l'autre avoir le dessus sur moi.	1	2	3	4	5	6
47. Je suis tellement occupé(e) à me dévouer pour les gens qui m'importent que j'ai très peu de temps pour moi.	1	2	3	4	5	6
48. Il m'est difficile d'avoir l'esprit libre et d'être spontané(e) avec les autres.	1	2	3	4	5	6
49. Je dois faire face à toutes mes responsabilités.	1	2	3	4	5	6
50. Je déteste être contraint(e) ou qu'on m'empêche de faire ce que je veux.	1	2	3	4	5	6
51. Il m'est très difficile de sacrifier une gratification immédiate pour mener à bien un projet à long terme.	1	2	3	4	5	6
52. À moins d'obtenir beaucoup d'attention des autres, je me sens peu important(e).	1	2	3	4	5	6
53. On n'est jamais assez prudent ; il peut toujours se produire quelque chose de mauvais.	1	2	3	4	5	6
54. Si je ne fais pas mon travail, je devrai en subir les conséquences.	1	2	3	4	5	6
55. Je n'ai eu personne qui m'écoute réellement, me comprenne et soit sensible à mes besoins et mes sentiments véritables.	1	2	3	4	5	6
56. Quand je sens que quelqu'un à qui je tiens s'éloigne de moi, je deviens désespéré(e).	1	2	3	4	5	6
57. Je suis très méfiant(e) quant aux motivations des autres.	1	2	3	4	5	6
58. Je me sens étranger(ère) aux autres, ou coupé(e) des autres.	1	2	3	4	5	6
59. J'ai le sentiment d'être quelqu'un que l'on ne peut pas aimer.	1	2	3	4	5	6
60. Je n'ai pas autant de talent que les autres au travail (ou à l'école).	1	2	3	4	5	6
61. On ne peut se fier à mon jugement dans les situations quotidiennes.	1	2	3	4	5	6
62. J'ai peur de perdre mon argent et de devenir démuni(e) ou très pauvre.	1	2	3	4	5	6
63. J'ai souvent l'impression que mes parents vivent à travers moi – je n'ai pas une vie qui me soit propre.	1	2	3	4	5	6
64. Je laisse toujours les autres choisir à ma place, si bien que je ne sais pas vraiment ce que je veux moi-même.	1	2	3	4	5	6
65. J'ai toujours été celui (celle) qui écoute les problèmes des autres.	1	2	3	4	5	6
66. Je me contrôle tellement bien que les autres croient que je n'ai pas d'émotions.	1	2	3	4	5	6
67. Je ressens une pression constante qui me force à faire les choses et à les réussir.	1	2	3	4	5	6

68. Je crois que je n'ai pas à suivre les règles et les conventions comme les autres.	1	2	3	4	5	6
69. Je ne peux pas me forcer à faire des choses qui ne me plaisent pas même quand je sais que c'est pour mon bien.	1	2	3	4	5	6
70. Si j'interviens lors d'une réunion ou si on me présente dans un groupe, il est important pour moi d'être reconnu(e) et admiré(e).	1	2	3	4	5	6
71. Même si je travaille beaucoup, j'ai peur de me retrouver un jour sans le sou.	1	2	3	4	5	6
72. Peu importe les raisons, quand je fais une erreur, je devrais en payer le prix.	1	2	3	4	5	6
73. Je n'ai pas eu une personne forte pour me donner de bons conseils ou pour me guider lorsque je ne savais pas quoi faire.	1	2	3	4	5	6
74. Quelquefois j'ai tellement peur que les gens m'abandonnent que je les repousse.	1	2	3	4	5	6
75. Je m'interroge habituellement sur les véritables intentions des autres.	1	2	3	4	5	6
76. Je me sens toujours à l'extérieur des groupes.	1	2	3	4	5	6
77. Je suis trop fondamentalement inacceptable pour me révéler aux autres ou pour les laisser bien me connaître.	1	2	3	4	5	6
78. Je ne suis pas aussi intelligent(e) que la plupart des gens quand il s'agit du travail (ou de l'école).	1	2	3	4	5	6
79. Je n'ai pas confiance dans ma capacité à résoudre les problèmes qui se posent tous les jours.	1	2	3	4	5	6
80. J'ai peur d'avoir une maladie grave, même si rien de sérieux n'a été diagnostiqué par un médecin.	1	2	3	4	5	6
81. J'ai souvent l'impression de ne pas avoir une identité distincte de celle de mes parents ou de mon(ma) partenaire.	1	2	3	4	5	6
82. J'ai beaucoup de difficultés à exiger que mes droits soient respectés et que mes sentiments soient pris en compte.	1	2	3	4	5	6
83. On me voit comme quelqu'un qui en fait trop pour les autres et pas assez pour lui(elle)-même.	1	2	3	4	5	6
84. Les gens me trouvent coincé(e) sur le plan émotionnel.	1	2	3	4	5	6
85. Je ne peux pas accepter de me dégager aisément d'une situation difficile ou de présenter des excuses pour mes erreurs.	1	2	3	4	5	6
86. J'ai le sentiment que j'ai beaucoup plus à offrir que les autres.	1	2	3	4	5	6
87. J'ai rarement été capable de tenir mes engagements.	1	2	3	4	5	6
88. Lorsqu'on me fait beaucoup de compliments et d'éloges, je me sens une personne de valeur.	1	2	3	4	5	6
89. J'ai peur qu'une mauvaise décision ne puisse conduire à un désastre.	1	2	3	4	5	6
90. Je suis quelqu'un de mauvais qui mérite d'être puni.	1	2	3	4	5	6

Les 18 schémas précoces inadaptés sont :
- manque affectif : items 1, 19, 37, 55, 73;
- abandon : items 2, 20, 38, 56, 74;
- méfiance et abus : items 3, 21, 39, 57, 75;
- isolement social : items 4, 22, 40, 58, 76;
- imperfection-honte : items 5, 23, 41, 59, 77;
- échec : items 6, 24, 42, 60, 78;
- dépendance-incompétance : items 7, 25, 43, 61, 79;
- peur du danger ou de la maladie (vulnérabilité) : items 8, 26, 44, 62, 80;
- fusionnement : items 9, 27, 45, 63, 81;
- assujettissement : items 10, 28, 46, 64, 82;
- abnégation : items 11, 29, 47, 65, 83;
- surcontrôle émotionnel : items 12, 30, 48, 66, 84;
- idéaux exigeants : items 13, 31, 49, 67, 85;
- droits personnels exagérés : items 14, 32, 50, 68, 86;
- contrôle de soi-autodiscipline insuffisants : items 15, 33, 51, 69, 87;
- recherche d'approbation et de reconnaissance : items 16, 33, 51, 70, 88;
- négativité-pessimisme : items 17, 35, 53, 71, 89;
- punition : items 18, 36, 54, 72, 90.

Cotation : les sujets doivent donner une note de 1 (cela est complètement faux pour moi) à 6 (me décrit parfaitement). L'évaluateur doit considérer les réponses observées à chaque schéma. Eventuellement, il peut s'intéresser aux cinq domaines théoriques (regroupement des schémas précoces inadaptés) :
- domaine de séparation et de rejet composé des schémas 1 à 5;
- domaine de manque d'autonomie et de performance composé des schémas 6 à 9;
- domaine de manque de limites composé des schéma 14 et 15;
- domaine d'orientation vers les autres, composé des schémas 10, 11 et 16;
- domaine de survigilance et inhibition composé des schémas 12, 13, 17 et 18.

Annexe n°2 - BIG FIVE INVENTORY version française : BFI-Fr

Votre perception de vous-même

Pour chacun des énoncés, cochez le chiffre indiquant dans quelle mesure vous approuvez ou désapprouvez l'énoncé.

1. Désapprouve fortement
2. Désapprouve un peu
3. N'approuve ni ne désapprouve
4. Approuve un peu
5. Approuve fortement

Je me vois comme quelqu'un qui....

1. Est bavard(e)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2. A tendance à critiquer les autres	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
3. Travaille consciencieusement	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
4. Est déprimé(e), cafardeux(se)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
5. Est créatif(ve), plein d'idées originales	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
6. Est réservé(e)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
7. Est serviable, et n'est pas égoïste avec les autres	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
8. Peut parfois être négligeant(e)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
9. Est « relax », détendu(e), gère bien le stress	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
10. S'intéresse à de nombreux sujets	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
11. Est plein(e) d'énergie	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
12. Commence facilement à se disputer avec les autres	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
13. Est fiable dans son travail	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
14. Peut-être angoissé(e)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
15. Est ingénieux(se), une grosse tête	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
16. Communique beaucoup d'enthousiasme	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
17. Est indulgent(e) de nature	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
18. A tendance à être désorganisé(e)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
19. Se tourmente beaucoup	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
20. A une grande imagination	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
21. A tendance à être silencieux(se)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
22. Fait généralement confiance aux autres	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
23. A tendance à être paresseux(se)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
24. Est quelqu'un de tempéré(e), pas facilement troublé(e)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
25. Est inventif(ve)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
26. A une forte personnalité, s'exprime avec assurance	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
27. Est parfois dédaigneux(se), méprisant(e)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

28. Persévère jusqu'à ce que sa tâche soit finie	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
29. Peut être lunatique, d'humeur changeante	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
30. Apprécie les activités artistiques et esthétiques	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
31. Est quelque fois timide, inhibé(e)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
32. Est prévenant(e) et gentil(le) avec presque tout le monde	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
33. Est efficace dans son travail	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
34. Reste calme dans les situations angoissantes	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
35. Préfère un travail simple et routinier	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
36. Est sociable, extraverti(e)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
37. Est parfois impoli(e) avec les autres	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
38. Fait des projets et les poursuit	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
39. Est facilement anxieux(se)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
40. Aime réfléchir et jouer avec des idées	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
41. Est peu intéressé(e) par tout ce qui est artistique	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
42. Aime coopérer avec les autres	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
43. Est facilement distrait(e)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
44. A de bonnes connaissances en art, musique ou littérature	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
45. Cherche des histoires aux autres	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

Cotation

Chaque facteur correspond à la moyenne de la somme des énoncés en inversant les scores des énoncés marqué d'un R.

Le score lié à la **dimension E (Extraversion, Énergie et Enthousiasme)** est la moyenne de la somme des énoncés suivants : 1, 6 R, 11 , 16 , 21 R, 26, 31 R, 36
Le score lié à la **dimension A (Agréabilité, Altruisme et Affection)** est la moyenne de la somme des énoncés suivants : 2 R, 7, 12 R, 17 , 22 , 27 R, 32, 37 R, 42, 45 R
Le score lié à la **dimension C (Conscienciosité, Contrôle, Contrainte)** est la moyenne de la somme des énoncés suivants : 3, 8 R, 13, 18 R, 23 R, 28 , 33 , 38 , 43 R
Le votre score lié à la **dimension N (Émotions Négatives, Névrosisme, Nervosité)**, est la moyenne de la somme des énoncés suivants : 4, 9 R, 14 , 19 , 24 R, 29, 34 R, 39
Le score lié à la **dimension O (Ouverture, Originalité, Ouverture d'esprit)** est la moyenne de la somme des énoncés suivants : 5, 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 R, 40, 41 R, 44

Annexe n°3 - MASLACH BURNOUT INVENTORY : MBI

Votre perception du travail

jamais = 0 ; quelques fois par an = 1; une fois par mois = 2; quelques fois par mois = 3; une fois par semaine. = 4; quelques fois par semaine = 5; tous les jours = 6

01 – Je me sens émotionnellement vidé(e) par mon travail	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
02 - Je me sens à bout à la fin de ma journée de travail	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
03 - Je me sens fatigué(e) lorsque je me lève le matin et que j'ai à affronter une autre journée de travail	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
04 - Je peux comprendre facilement ce que mes patients/clients/élèves ressentent	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
05 - Je sens que je m'occupe de certains patients/clients/élèves de façon impersonnelle, comme s'ils étaient des objets	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
06 - Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande beaucoup d'efforts	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
07 - Je m'occupe très efficacement des problèmes de mes patients/clients/élèves	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
08 - Je sens que je craque à cause de mon travail	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
09 - J'ai l'impression, à travers mon travail, d'avoir une influence positive sur les gens	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
10 - Je suis devenu(e) plus insensible aux gens depuis que j'ai ce travail	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
11 - Je crains que ce travail ne m'endurcisse émotionnellement	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
12 - Je me sens plein(e) d'énergie	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
13 - Je me sens frustré(e) par mon travail	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
14 - Je sens que je travaille « trop dur » dans mon travail	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
15 - Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes patients/clients/élèves	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
16 - Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
17 - J'arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec mes patients/clients/élèves	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
18 - Je me sens ragaillardi(e) lorsque dans mon travail j'ai été proche de patients/clients/élèves	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
19 - J'ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
20 - Je me sens au bout du rouleau	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
21 - Dans mon travail, je traite les problèmes émotionnels très calmement	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
22 - J'ai l'impression que mes patients/clients/élèves me rendent responsable de certains de leurs problèmes	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

Interprétation :

Pour le score d'EE : additionner les questions 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 :
BOS bas : score < 18 ; BOS modéré : 18 à 29; BOS élevé : > 29

Pour le score de DP : additionner les questions 5, 10, 11, 15, 22 :
BOS bas : <6; BOS modéré : 6-11; BOS élevé : > 11

Pour le score d'AP additionner les questions 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 :
BOS élevé : < 34; BOS modéré : 34-39; BOS bas : > 39

Annexe n°4 - INDEX DE REACTIVITE INTERPERSONELLE

Le questionnaire suivant concerne vos pensées et vos sentiments dans différentes situations. Pour chaque item, indiquez dans quelle mesure la phrase vous correspond en choisissant la lettre appropriée sur l'échelle décrite ci-dessous: A, B, C, D, ou E. Quand vous avez choisi votre réponse, entourez la.
LISEZ CHAQUE ITEM ATTENTIVEMENT AVANT DE RÉPONDRE. Répondez le plus honnêtement possible. Merci.

Échelle de cotation :

A	B	C	D	E
Ne me décrit pas vraiment				Me décrit très bien

1. J’imagine et fantasme assez régulièrement sur des choses qui pourraient m'arriver. (FS)
2. Je suis souvent sensible à l’égard des gens qui ont moins de chance que moi et me préoccupe de leur sort. (EC)
3. J’ai parfois des difficultés à imaginer les choses du point de vue d’une autre personne. (PT) (-)
4. Parfois, je ne me sens pas vraiment désolé(e) pour les autres lorsqu'ils ont des problèmes. (EC) (-)
5. Je m’identifie complètement par les sentiments aux personnages d'un roman (FS)
6. Dans les situations d'urgences, je me sens inquiet(e) et mal à l’aise. (PD)
7. Je suis habituellement objectif (ve) lorsque je regarde un film ou une pièce de théâtre, et je ne me laisse pas souvent captiver entièrement dans l'action. (FS) (-)
8. En cas de désaccord, j'essaie de considérer le point de vue de chacun avant de prendre une décision (PT)
9. Lorsque je vois que l'on profite de quelqu'un, j’éprouve une certaine envie de le protéger. (EC)
10. Quand je me retrouve dans une situation très émouvante, je me sens parfois incapable de réagir. (PD)
11. J'essaie parfois de mieux comprendre mes amis en imaginant comment les choses se présentent de leur point de vue. (PT)
12. Se sentir totalement impliqué(e) dans un bon livre ou un bon film est assez rare pour moi. (FS) (-)
13. Lorsque je vois quelqu'un souffrir, j'ai tendance à garder mon sang froid. (PD) (-)

14. Habituellement, le malheur des autres ne me perturbe pas particulièrement. (EC) (-)
15. Si je suis sûr(e) que j'ai raison , je ne perds pas mon temps à écouter les arguments des autres. (PT) (-)
16. Après avoir vu une pièce de théâtre ou un film, il m'est arrivé de me sentir dans la peau d'un des personnages (FS)
17. Je suis effrayé(e) à l'idée de me retrouver dans une situation émotionnellement tendue. (PD)
18. Lorsque je vois une personne traitée injustement, il m'arrive parfois de ne pas ressentir beaucoup de pitié pour elle. (EC) (-)
19. Je suis habituellement efficace dans la gestion des situations d'urgence. (PD) (-)
20. Je suis souvent touché(e) par des événements dont je suis témoin. (EC)
21. Je crois qu'il y a deux facettes à chaque question et j'essaie de prendre en considération toutes les deux. (PT)
22. Je me décrirais comme une personne qui s'attendrit plutôt facilement. (EC)
23. Lorsque je regarde un bon film, je peux très facilement me mettre à la place d'un des personnages principaux (FS)
24. J'ai tendance à perdre mon sang-froid dans les situations d'urgence. (PD)
25. Quand je suis en colère contre quelqu'un, j'essaye généralement de me mettre à sa place un instant. (PT)
26. Lorsque je lis un roman (ou une histoire) intéressant, j'imagine comment je me sentirais si les événements de l'histoire m'arrivaient. (FS)
27. Quand je vois quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide dans une situation d'urgence, je perds mes moyens. (PD)
28. Avant de critiquer quelqu'un, j'essaie d'imaginer ce que je ressentirais si j'étais à sa place. (PT)

L'IRI est un auto-questionnaire de 28 items pour lesquels le sujet doit attribuer une note allant de 1 (ne me décris pas vraiment) à 5 (me décris très bien) selon l'affirmation qui lui est présentée. Les scores possibles à l'échelle d'empathie de Davis (IRI) vont de 28 à 140 (28 items cotés de 1 à 5). Le score global correspond à la somme des scores à 4 sous-échelles permettant de distinguer l'empathie affective et l'empathie cognitive :

Cotation : (-) indique que l'item doit être noté en « reverse »
A=1 B=2 C=3 D=3 4=5; pour le reverse : A=5 B=4 C=3 D=2 E=1

Annexe n°5 - LIFE EVENT CHECKLIST for DSM-5

Vous et vos événements de vie stressants

Voici une liste de situations difficiles ou stressantes qu'une personne peut avoir à subir. Pour chaque événement, veuillez cocher une ou plusieurs cases de droite pour indiquer que : (a) vous avez **personnellement** vécu une telle situation ; (b) vous **avez été témoin** d'une telle situation vécue par une autre personne ; (c) vous **avez appris** qu'une telle situation était arrivée **à l'un de vos proches** ; (d) vous y avez été exposé **dans le cadre de votre travail**; (e) vous êtes **incertain** ou (f) cela **ne s'applique pas à vous.**

Evènement	**Cela m'est arrivé**	**J'en ai été témoin**	**Je l'ai appris**	**Fait partie de mon travail**	**Incertain**	**Ne s'applique pas à moi**
1. Catastrophe naturelle (inondation, ouragan, tornade, tremblement de terre, etc…)						
2. Incendie ou explosion						
3. Accident de la route (accident de voiture ou de bateau, déraillement de train, écrasement d'avion,etc)						
4. Accident grave de travail, à domicile ou pendant des occupations de loisirs.						
5. Exposition à une substance toxique (produits chimiques dangereux, radiations, etc. .)						
6. Agression physique (avoir été attaqué, frappé, poignardé, battu, roué de coups, etc.)						
7. Attaque à main armée (avoir été blessé par arme à feu ou arme tranchante, avoir été menacé avec un couteau, une arme à feu ou une bombe, etc.)						
8. Agression sexuelle (viol, tentative de viol, accomplir tout acte sexuel par la force ou sous des menaces)						
9. Autre expérience sexuelle non désirée et désagréable (abus sexuel dans l'enfance)						
10. Participation à un conflit armé ou présence dans une zone de guerre (dans l'armée ou comme civil).						

11. Captivité (avoir été kidnappé, enlevé, pris en otage, incarcéré comme prisonnier de guerre, etc.)						
12. Maladie ou blessure mettant la vie en danger						
13. Souffrances humaines intenses						
14. Mort violente (homicide, suicide, etc.)						
15. Mort subite et inattendue d'un proche						
16. Blessure grave, dommage ou mort causés par vous à quelqu'un						
17. Toute autre expérience très stressante (négligence dans l'enfance, etc.) Préciser……						

Si vous avez répondu positivement à plusieurs événements, **veuillez-indiquer l'événement** que vous considérez comme **étant le plus stressant** pour vous et répondez au questionnaire par rapport à cet événement.

……

Age au traumatisme index : ……..

Age au début des symptômes : ……..

Annexe n°6 - PERITRAUMATIC DISTRESS INVENTORY

Veuillez compléter le questionnaire en entourant le nombre qui décrit le mieux l'expérience que vous avez vécu **pendant l'événement traumatique et dans les minutes et les heures qui ont suivi**. Si les items ne s'appliquent pas à votre expérience, veuillez entourer «pas du tout vrai ».

	Pas du tout vrai	Un peu vrai	Plutôt vrai	Très vrai	Extrêmement vrai
Je me sentais impuissant(e), dépassé(e)	0	1	2	3	4
Je ressentais de la tristesse et du chagrin	0	1	2	3	4
Je me sentais frustré(e), insatisfait(e) et en colère	0	1	2	3	4
J'avais peur pour ma propre sécurité	0	1	2	3	4
Je me sentais coupable	0	1	2	3	4
J'avais honte de mes émotions, ce que je ressentais	0	1	2	3	4
J'étais inquiet(e) pour la sécurité des autres (mes parents, mes frères et sœurs, mes amis etc…)	0	1	2	3	4
J'avais l'impression de perdre le contrôle de mes émotions, de ne plus maitriser ce que je ressentais	0	1	2	3	4
J'avais envie d'uriner, d'aller à la selle	0	1	2	3	4
J'étais horrifié(e), effrayé(e)	0	1	2	3	4
J'avais des sueurs, des tremblements, le cœur qui battait fort et vite (palpitations)	0	1	2	3	4
Je sentais que je pouvais m'évanouir	0	1	2	3	4
Je pensais que je pourrais mourir	0	1	2	3	4

Au cours du mois écoulé, avez-vous souvent pensé de façon pénible à cet événement ?

(par exemple par le biais de cauchemars, de flashbacks, évitement des rappels du traumatisme) ou étiez vous pris(e) d'angoisse lorsque quelque chose ou quelqu'un vous rappelait l'événement traumatique ?

Si NON : ne pas remplir le questionnaire suivant (PCL-5)

Si OUI : remplir le questionnaire suivant (PCL-5)

Chacun des 13 items est coté de 0 (pas du tout vrai) à 4 (extrêmement vrai). Le score total est la somme de tous les items. Un score à partir de 15 indique une détresse significative.

Annexe n° 7 - PTSD CHECK LIST for DSM-5; PCL-5

Dans le dernier mois, dans quelle mesure avez-vous été affecté(e) par :	Pas du tout	Un peu	Moyennement	Souvent	Extrêmement
1. Des souvenirs répétés, pénibles et involontaires de l'expérience stressante ?	0	1	2	3	4
2. Des rêves répétés et pénibles de l'expérience stressante ?	0	1	2	3	4
3. Se sentir soudainement comme si l'expérience stressante recommençait (comme si vous la viviez à nouveau) ?	0	1	2	3	4
4. Etre bouleversé(e) lorsque quelque chose vous rappelle l'expérience stressante ?	0	1	2	3	4
5. Réagir physiquement lorsque quelque chose vous rappel l'expérience stressante (p. ex., avoir le coeur qui bat très fort, du mal à respirer, ou avoir des sueurs) ?	0	1	2	3	4
6. Eviter souvenirs, pensées ou sentiments en lien avec l'expérience stressante ?	0	1	2	3	4
7. Eviter les personnes et les choses qui vous rappellent l'expérience stressante (p. ex., des gens, des lieux, des conversations, des activités, des objets, ou des situations) ?	0	1	2	3	4
8. Avoir du mal à vous rappeler d'éléments importants de l'expérience stressante ?	0	1	2	3	4
9. Avoir des croyances négatives sur vous-même, les autres ou sur le monde (p. ex., avoir des pensées telles que : je suis mauvais(e), il y a quelque chose qui cloche sérieusement chez moi, nul n'est digne de confiance, le monde est un endroit complètement dangereux) ?	0	1	2	3	4
10. Vous blâmer ou blâmer les autres pour la survenue de l'expérience stressante ou ce qui est arrivé par la suite ?	0	1	2	3	4
11. Avoir des sentiments négatifs intenses tels que peur, horreur, colère, culpabilité, ou honte ?	0	1	2	3	4
12. Perdre de l'intérêt pour des activités que vous aimiez auparavant ?	0	1	2	3	4
13. Vous sentir distant(e) ou coupé(e) des autres ?	0	1	2	3	4
14. Avoir du mal à éprouver des sentiments positifs (p.ex., être incapable de ressentir la joie ou de l'amour envers vos proches) ?	0	1	2	3	4
15. Etre irritable, avoir des bouffées de colère, ou agir agressivement ?	0	1	2	3	4
16. Prendre des risques inconsidérés ou encore avoir des conduites qui pourraient vous mettre en danger ?	0	1	2	3	4
17. Etre « super-alerte », vigilant(e) ou sur vos gardes ?	0	1	2	3	4
18. Sursauter facilement ?	0	1	2	3	4
19. Avoir du mal à vous concentrer ?	0	1	2	3	4
20. Avoir du mal à trouver ou garder le sommeil ?	0	1	2	3	4

La notation du PCL-5 peut se faire de plusieurs façons différentes :

-Un score total pour la gravité des symptômes (0-80) peut être obtenu en additionnant le score de chacun des 20 items.

-Le score de gravité pour chacun des critères de symptômes dans le DSM-5 peut être obtenu en additionnant le score des items contenus correspondant à chaque critère, soit B (items 1-5), C (items 6-7), D (items 8-14), et E (items 15-20).

-Un diagnostic provisoire peut être obtenu en considérant tout item avec un score de 2 et plus comme étant présent, et ensuite en adhérant aux instructions du DSM-5 qui requièrent au moins : 1 item B (questions 1-5), 1 item C (questions 6- 7), 2 items D (questions 8-14), et 2 items E (questions 15-20).

Un seuil de 38 au PCL-5 semble raisonnable pour suggérer la présence d'un ESPT.

Annexe n°8 - POST TRAUMATIC GROWTH INVENTORY : PTGI

Depuis l'évènement stressant

Veuillez indiquer, pour chacune des affirmations ci-dessous, le degré auquel ces changements se sont produits dans votre vie comme un résultat de l'expérience de l' événement stressant. Entourez votre réponse.

-Je ne ressens pas ce changement = **0**
- Je ressens ce changement à un très faible degré = **1**
- Je ressens ce changement à un faible degré = **2**
- Je ressens ce changement à un degré modéré. = **3**
- Je ressens ce changement à un degré élevé. = **4**
- Je ressens ce changement à un degré très élevé = **5**

1- Mes priorités sur ce qui est important dans la vie ont changé.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
2- Je considère la valeur de ma vie différemment.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
3- J'ai de nouveaux centres d'intérêts.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
4- Je compte davantage sur moi.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
5- J'ai une meilleure compréhension des questions spirituelles.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
6- Je sais que je peux compter sur les autres en cas de problèmes.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
7- J'ai donné une nouvelle orientation à ma vie.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
8- Je me sens plus proche des gens	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
9- J'exprime plus volontiers mes émotions.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
10- Je sais que je peux gérer les difficultés	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
11- Je suis capable de faire de meilleures choses dans ma vie.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
12-Je suis capable d'accepter la façon dont les choses arrivent.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
13- J'apprécie chaque jour.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
14- De nouvelles opportunités sont apparues, ce qui n'aurait pas été le cas auparavant	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
15- J'ai d'avantage de compassion pour les autres.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
16- Je m'investis d'avantage dans mes relations.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
17- Je suis plus enclin à changer ce qui doit l'être	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
18- Ma foi religieuse est plus forte.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
19- J'ai découvert que j'étais plus fort(e) que je pensais l'être.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
20- J'ai appris à quel point les gens peuvent être merveilleux	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
21- J'accepte mieux d'avoir besoin des autres.	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

Le score total est la somme de tous les items (score maximum 105 points).

L'analyse se compose de 5 sous-échelles :

-Relation aux autres (items 6, 8, 9, 15, 16, 20, 21)

-Nouvelles possibilités (items 3, 7, 11, 14, 17)

-Force personnelle (items 4, 10, 12, 19)

-Changement spirituel (items 5, 18)

-Appréciation de la vie (items 1,2, 13)

Annexe n°9 - TROUBLE DE STRESS POST TRAUMATIQUE

L'expression « événement traumatique », plutôt que « un ou plusieurs », est utilisée afin d'alléger le texte.

A Exposition à la mort, à des blessures graves, ou à la violence sexuelle, effectives ou potentielles, d'une (ou plusieurs) des façons suivantes :

1 Vivre directement l'événement traumatique.

2 Être témoin, en personne, de l'événement vécu par d'autres.

3 Apprendre que l'événement traumatique a été vécu par un membre de la famille proche ou un ami proche. Note : En cas de décès ou de danger de décès d'un membre de la famille ou d'un ami, l'événement doit avoir été violent ou accidentel.

4 Vivre une exposition répétée ou extrême aux détails pénibles de l'événement traumatique (par exemple, les premiers intervenants ou les policiers). Note : Le critère A4 ne s'applique pas à l'exposition par le biais des médias électroniques, de la télévision, de films ou de photos, à moins que cette exposition soit liée au travail.

B Présence d'un (ou plusieurs) des symptômes intrusifs suivants associés à l'événement traumatique, ayant débuté après ce dernier :

1 Souvenirs pénibles récurrents, involontaires, et envahissants de l'événement traumatique. Note : Chez les enfants âgés de plus de 6 ans, il peut s'agir d'un jeu répétitif dans lequel des thèmes ou des aspects de l'événement traumatique sont exprimés.

2 Rêves répétitifs pénibles dans lesquels le contenu et/ou l'affect sont liés à l'événement traumatique. Note : Chez les enfants, il peut s'agir de rêves effrayants sans contenu reconnaissable.

3 Réactions dissociatives (flash-backs, par exemple) dans lesquelles l'individu se sent ou agit comme si l'événement traumatique se reproduisait. (De telles réactions peuvent survenir sur un continuum, l'expression la plus extrême étant une perte totale de conscience de l'environnement actuel.) Note : Chez les enfants, des reconstitutions du traumatisme peuvent se produire dans le jeu.

4 Détresse psychologique intense ou prolongée à l'exposition à des indices internes ou externes évoquant ou ressemblant à un aspect de l'événement traumatique.

5 Réactions physiologiques marquées à des indices internes ou externes

évoquant ou ressemblant à un aspect de l'événement traumatique.

C Évitement persistant des stimuli associés à l'événement traumatique ayant débuté après ce dernier, comme en témoigne(nt) une ou les deux manifestations suivantes :

1 Évitement ou efforts pour éviter les souvenirs, les pensées ou les sentiments pénibles à propos de, ou étroitement associés à, l'événement traumatique.

2 Évitement ou efforts pour éviter les rappels externes (personnes, lieux, conversations, activités, objets, situations) qui éveillent des souvenirs, des pensées ou des sentiments pénibles à propos de, ou étroitement associés à, l'événement traumatique.

D Altérations négatives des cognitions et de l'humeur associées à l'événement traumatique, ayant débuté ou s'étant aggravées après ce dernier, comme en témoignent deux (ou plus) des manifestations suivantes :

1 Incapacité de se rappeler un aspect important de l'événement traumatique (typiquement en raison d'une amnésie dissociative et non d'autres facteurs tels que blessure à la tête, alcool ou drogues).

2 Croyances ou attentes négatives persistantes ou exagérées à propos de soi-même, des autres, ou du monde (par exemple, « Je suis mauvais », « On ne peut faire confiance à personne », « Le monde est complètement dangereux », « Mon système nerveux entier est définitivement ruiné ».

3 Cognitions persistantes et déformées concernant la cause ou les conséquences de l'événement traumatique qui amènent l'individu à se blâmer ou à blâmer autrui.

4 État émotionnel négatif persistant (par exemple, peur, horreur, colère, culpabilité ou honte).

5 Diminution marquée de l'intérêt ou de la participation à des activités significatives.

6 Sentiment de détachement ou d'éloignement des autres.

7 Incapacité persistante de ressentir des émotions positives (par exemple, incapacité à éprouver du bonheur, de la satisfaction ou des sentiments affectueux).

E Altérations marquées dans l'activation et la réactivité associées à l'événement traumatique, ayant débuté ou s'étant aggravées après ce dernier, comme en témoignent deux (ou plus) des manifestations suivantes :

1 Comportement irritable et crises de colère (avec peu ou pas de provocation) généralement sous forme d'agression verbale ou physique envers des personnes ou des objets.
2 Comportement imprudent ou autodestructeur.
3 Hypervigilance.
4 Réaction de sursaut exagérée.
5 Problèmes de concentration.
6 Troubles du sommeil (par exemple, difficultés à s'endormir ou à rester endormi ou sommeil agité).

F La durée de la perturbation (critères B, C, D, et E) est de plus que 1 mois.

G La perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement dans les domaines sociaux, professionnels, ou autres domaines importants.

H La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (par exemple, médicaments, alcool) ou d'une autre condition médicale.

Spécificateurs

Avec symptômes dissociatifs

Les symptômes rencontrent les critères d'un trouble de stress post-traumatique, et en plus, en réponse au stress, la personne vit des symptômes persistants et récurrents tels que l'une des manifestations suivantes :

1 Dépersonnalisation : expériences persistantes ou récurrentes d'un sentiment de détachement, et d'être un observateur extérieur de ses processus mentaux ou corporels (par exemple, sentiment d'être dans un rêve ; sentiment d'irréalité de soi ou de son corps ou que le temps se déroule lentement).
2 Déréalisation : expériences persistantes ou récurrentes d'irréalité de l'environnement (par exemple, l'environnement immédiat est vécu comme irréel, onirique, lointain, ou déformé).

Note : Pour utiliser ce sous-type, les symptômes dissociatifs ne doivent pas être imputables aux effets physiologiques d'une substance (par exemple, intoxication alcoolique) ou à une autre condition médicale (par exemple, crises épileptiques partielles).

Avec expression retardée

Ce spécificateur est utilisé si tous les critères diagnostiques ne sont remplis que 6 mois après l'événement (bien que l'apparition et l'expression de certains symptômes puissent être immédiates).

Diagnostics de stress aigu et de trouble de l’adaptation

Un diagnostic d'état de stress aigu est posé si, de 3 jours à 1 mois après l'événement traumatique, tous les symptômes du stress post-traumatique sont rencontrés.
Ce diagnostic est remplacé par celui de stress post-traumatique après un mois.

Un diagnostic de trouble de l'adaptation est considéré,

- lorsque la réponse à un événement traumatique ne rencontre pas tous les critères de l'état de stress aigu ;
- ou lorsque l'exposition à un événement stressant ne correspond pas aux critères de l'exposition à un événement traumatique.

RÉSUMÉ

INTRODUCTION. 49% des médecins Français souffrent de Syndrome d'Epuisement Professionnel (SEP) et le Trouble de Stress Post-Traumatique (TPST) est 3 fois plus fréquent chez les soignants. Plusieurs études ont montré que les psychologues qui avaient les Schémas Précoces Inadaptés (SPI) idéaux exigeants et abnégation avaient un fort taux d'Epuisement Emotionnel (EE); que le Névrosisme prédisait l'EE et que plus le niveau de SEP des médecins généralistes était élevé, plus leur empathie était faible.
La présence de SPI et d' un Névrosisme élevé expose à un TPST.

OBJECTIFS. L'objectif de cette étude était de rechercher un lien entre certains SPI et l'apparition d'un BO et/ou d'un TSPT. Secondairement, de savoir si les premiers répondeurs sont représentatifs de la population étudiée.

METHODES. Les participants à l'étude étaient constitués d'une promotion d'étudiants en 1ère année du troisième cycle des études médicales de médecine générale de l'Université de Poitiers. 83,6% des étudiants (N=92, âge = 25,5 ans) ont participé. Le Young's Schema Questionnaire, 3ème version courte (YSQ-S3), le Big Five Inventory version Française (BFI-Fr), Maslach Burnout Inventory (MBI), l'Index de Réactivité Interpersonnelle (IRI), le Life Event Checklist for DSM 5 (LEC-5), le Peritraumatic Distress Inventory (PDI), le Post Traumatic Stress Disorder Check List for DSM 5 (PCL-5) et le Post Traumatic Growth Inventory (PTGI) leur ont été proposés.

RESULTATS. Les résultats ont mis en évidence 3 profils de personnalité significativement différents selon le YSQ-S3 (cluster 1 n=46, cluster 2 n=18, cluster 3 n=28). Le cluster 3 présentait des SPI Surcontrôle Emotionnel, Idéaux Exigeants et Punition significativement plus élevés que les clusters 1 et 2. Les clusters 1 et 3 avaient un score significativement plus élevé d'Epuisement Emotionnel (EE) ainsi qu'un Névrosisme et une Ouverture plus élevés que le cluster 2. Le cluster 3 avait une dépersonnalisation (DEP) significativement plus élevée que le cluster 2.
Le taux d'exposition à au moins un événement traumatique était de 93,5% avec 20,5% des étudiants qui déclaraient avoir été exposés à une souffrance humaine intense dans leur travail.
Les premiers répondeurs étaient représentatifs de la population étudiée.

CONCLUSION. La présence des SPI Surcontrôle Emotionnel, Idéaux Exigeants et Punition est significativement lié à un EE et une DEP plus élevés. Ces mêmes SPI présentaient un Névrosisme et une Ouverture plus élevés.

Mots clés : Schéma précoces inadaptés, cinq grands facteurs de personnalité, Syndrome d'épuisement professionnel, empathie, trouble de stress post-traumatique

UNIVERSITÉ DE POITIERS

Faculté de Médecine et de Pharmacie

SERMENT

En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples et devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe ; ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leurs pères.

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ! Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque !